راهنمای حمایت روان‌شناختی از کارکنان سلامت در بحران

ویژه متخصصان سلامت روان

انجمن علمی روان‌پزشکان ایران

فروردین ۱۴۰۵

نظارت علمی:

دکتر مریم رسولیان

دکتر مریم طباطبایی مطلق

گردآوری و تدوین:

دکتر مریم طباطبایی مطلق

دکتر مریم رسولیان

دکتر امیر شعبانی

دکتر مریم محققی

دکتر بهرنگ شادلو

دکتر کیمیا کوگانی

دکتر ندا مسجدی

دکتر نیکا کشتکاران

دکتر آیدا باوند

فهرست عناوین

- **مقدمه**.....٤
- **بخش اول:** حمایت روانی‌اجتماعی همتایان.....٧
- **بخش دوم:** کمک‌های اولیه روان‌شناختی.....١٨
- **بخش سوم:** بحران وتروما.....٢٤
- **بخش چهارم:** سوگ.....٤١
- **بخش پنجم:** خودمراقبتی متخصصان سلامت روان.....٦٥
- **بخش ششم:** ارجاع و ملاحظات فرهنگی حرفه‌ای.....٧٢
- **منابع** ٧٦
- **پیوست**.....٧٩

مقدمه

در ماه‌ها و روزهای اخیر، تجربه جنگ، بی‌ثباتی و ناامنی، جامعه را با بحرانی عمیق و چندلایه مواجه ساخته؛ بحرانی که پیامدهای گسترده و قابل‌توجهی بر سلامت روان افراد و گروه‌ها به جا گذاشته است. سوگ جمعی، تجربه‌های آسیب‌زا (تروما)، ابهام و اضطراب فراگیر، در سطح فردی، بین‌فردی، نهادی و اجتماعی، به شکل‌گیری و تداوم این وضعیت دامن زده‌اند.

در این میان، کارکنان نظام سلامت در موقعیتی دوگانه، پیچیده و گاه پرتنش قرار دارند. آنان از یک سو مسوولیت خطیر مراقبت از بیماران، ارایه خدمات درمانی و حفظ استانداردهای حرفه‌ای را به عهده دارند، و از سوی دیگر، خود نیز در معرض آسیب‌ها، فقدان‌ها و فشارهای مشابهند. تجربه زیسته در چنین بستری، صرفاً به فشار شغلی یا فرسودگی حرفه‌ای محدود نمی‌شود، بلکه ترکیبی از مواجهه با تروما، تعارض‌های اخلاقی، سوگ، و اضطراب ناشی از ناامنی و بی‌ثباتی است. این شرایط می‌تواند بر احساس معنا، انسجام روانی و هویت حرفه‌ای کارکنان سلامت نیز تأثیرگذار باشد.

این راهنما با هدف ارایه چارچوبی نظری و عملی برای متخصصان سلامت روان ـ شامل روان‌پزشکان، روان‌شناسان، مددکاران اجتماعی حوزه سلامت روان، و روان‌پرستاران ـ تدوین شده تا بتوانند در حمایت روانی‌اجتماعی از کارکنان نظام سلامت نقش مؤثرتری ایفا کنند.

این راهنما بر مداخله‌هایی تمرکز دارد که در شرایط بحرانی، محدودیت منابع و بی‌ثباتی نیز قابل اجرا باشند. آموزش‌های روان‌شناختی متناسب با بحران، تسهیل حمایت همتایان، و اجرای مداخله‌های کوتاه‌مدت و مبتنی بر شواهد، می‌تواند به ایجاد فضایی امن، منعطف و حمایت‌گر در محیط‌های درمانی کمک کند. تمرکز اصلی این برنامه بر تثبیت وضعیت روانی، کمک به تنظیم هیجانی، تقویت پیوندهای انسانی و همکارانه، و بازسازی حس کارآمدی و کفایت حرفه‌ای است. ورود به فرایندهای درمانی عمیق فردی یا مداخله‌های تخصصی بلندمدت، در حیطه هدف‌های این راهنما قرار نمی‌گیرد؛ بلکه تأکید بر اقداماتی است که بتوانند به حفظ حداقلی از ثبات روانی، معنا و همبستگی در شرایط دشوار کنونی یاری رسانند.

ساختار این راهنما به‌گونه‌ای طراحی شده که در بخش نخست، مدل‌هایی برای حمایت همتایان معرفی می‌شود که متخصصان سلامت روان می‌توانند با توجه به شرایط و امکانات مرکز درمانی خود، یک یا چند مورد از آن‌ها را انتخاب و اجرا کنند. در بخش‌های بعدی، محتوای آموزشی کاربردی در حوزه‌هایی همچون سوگ، تروما، کمک‌های اولیه روان‌شناختی و خودمراقبتی ارایه شده است. این مطالب می‌توانند هم در آموزش کارکنان نظام سلامت (کادر درمانی، اجرایی و پشتیبانی) و هم در طراحی و اجرای برنامه‌های حمایتی توسط متخصصان سلامت روان مورد استفاده قرار گیرند.

در صورت برخورد با مشکلات علمی یا اجرایی در مسیر پیاده کردن این برنامه، و همچنین برای طرح پرسش‌ها یا ارایه بازخورد، می‌توانید از طریق راه‌های زیر با مسوولان این پروژه در انجمن روان‌پزشکان ایران در تماس باشید:

پست الکترونیک: info@psychiatrist.ir یا tabatabaee@sina.tums.ac.ir

تلفن تماس : ۰۹۹۰۶۴۹۴۶۸۰ (در ساعات اداری روزهای کاری)

فرم آنلاین : https://survey.porsline.ir/s/BVEVUyKu

بخش اول

حمایت روانی‌اجتماعی همتایان

اهمیت و اثربخشی حمایت همتایان

حمایت همتایان به معنای حمایت روانی و اجتماعی است که توسط افرادی با تجربه‌های مشابه ارایه می‌شود. این نوع حمایت بر درک متقابل، همدلی و پذیرش و معناسازی در زمان تجربه‌های دشوار استوار است. در شرایط تروما یا سوگ جمعی، زمانی که شمار زیادی از افراد هم‌زمان در معرض تجربه فشار روانی مشابهی قرار دارند، وجود یک برنامه ساختارمند برای حمایت می‌تواند نقش مؤثری در بازتوانی روانی فردی و جمعی ایفا کند.

در بحران‌های گسترده، فشار روانی کادر درمان صرفاً ناشی از مواجهه با بیماران نیست، بلکه از هم‌زمانی نقش حرفه‌ای و تجربه شخصی درگیری با تروما نیز سرچشمه می‌گیرد. هر فرد بسته به تجربه قبلی و چالش‌های فعلی در زندگی تجربه متفاوتی از بحران دارد و این تفاوت در تجربه و واکنش افراد به بحران طبیعی و قابل انتظار است. در بحران‌هایی مانند جنگ خطر فرسودگی هیجانی، ترومای ثانویه و آسیب اخلاقی افزایش می‌یابد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که حمایت روانی‌اجتماعی یکی از قوی‌ترین عامل‌های محافظتی در برابر ایجاد اختلال استرس پس از سانحه و سوگ پیچیده است. برای کادر درمان، این حمایت زمانی بیشترین اثربخشی را دارد که از سوی همکاران با تجربه مشترک ارایه شود؛ افرادی که زبان مشترک، زمینه کاری مشابه و تجربه زیسته قابل درک دارند.

یک گفت‌وگوی هم‌دلانه و شنیده شدن بدون قضاوت، در کاهش درد و رنج فرد اثربخش است. مطالعه‌ها نشان داده‌اند که افراد با به کلام در آوردن احساس و تجربه درونی‌شان، از شدت رنج‌شان کاسته شده و تا حد قابل‌توجهی تسکین می‌یابند. عمیق‌ترین زخم‌ها و ناملایمت‌های روانی در رابطه و از طریق کلام ایجاد می‌شوند و از طریق کلام و در رابطه‌ای امن هم بهبود می‌یابند. گفت‌وگو ـ یعنی به کلام درآوردن هیجان‌های خوشایند و ناخوشایند ـ سبب تقویت مدارهایی در مغز می‌شود که تفکر منطقی را فعال می‌کند و فرد را قادر می‌سازد تا تفکر غیرمنطقی و مبتنی بر هیجان‌های منفی را خود کنترل کند.

حمایت همتایان یک مداخله درمانی رسمی نیست، بلکه سازوکاری ساختارمند برای حمایت متقابل است که هدف آن تقویت تنظیم هیجانی، کاهش انزوای حرفه‌ای و افزایش تاب‌آوری فردی و سازمانی است. برنامه‌های حمایت همتایان می‌توانند به‌صورت رسمی و تسهیل‌شده، یا در قالب گروه‌های خودگردان، یا به صورت فردی اجرا شوند. در هر مدلی، سه عنصر «محرمانگی»، «اعتماد» و «تجربه زیسته مشترک» به‌عنوان ارکان اصلی اثربخشی شناخته شده‌اند.

پژوهش‌ها حاکی از آن است که این برنامه‌ها به عادی‌سازی تجربه‌های روانی، کاهش انگ، افزایش امید، تسهیل بیان هیجانی و تقویت شبکه‌های حمایت اجتماعی کمک می‌کنند. در برخی مطالعه‌ها، مشاهده شده افرادی که پیش‌تر از خدمات تخصصی سلامت روان استفاده نمی‌کردند، پس از مشارکت در چنین فضاهایی به درمان حرفه‌ای نیز متصل شده‌اند. هم‌چنین، این نوع مداخله‌ها می‌توانند شکاف میان نیاز و استفاده از خدمات سلامت روان را کاهش دهند.

در سطح فردی، حمایت همتایان اگرچه اختلال استرس پس از سانحه را درمان نمی‌کند، سوگ را حذف نمی‌کند و بحران بیرونی را تغییر نمی‌دهد، اما می‌تواند احساس تنهایی و بی‌پناهی را کاهش دهد، تنظیم هیجانی را تسهیل و احتمال فرسودگی مزمن را کم کند، حس معنا و امید را تقویت کند و مهارت‌های سازگارانه و انعطاف روانی را افزایش دهد. در سطح سازمانی، چنین ساختاری می‌تواند با تقویت حس همبستگی حرفه‌ای، کاهش ترک کار و کاهش غیبت‌های ناشی از فرسودگی، به حفظ ظرفیت عملکرد سیستم درمانی کمک کند.

در مجموع، در شرایط تروما و سوگ جمعی که کادر درمان خود گروهی از جمعیت آسیب‌دیده‌اند، حمایت همتایان یک مداخله کم‌هزینه، قابل اجرا در مقیاس گسترده و مبتنی بر سرمایه اجتماعی حرفه‌ای‌ست و کلید موفقیت آن نه در پیچیدگی ساختار، بلکه در سادگی، داوطلبانه بودن، محرمانگی، اعتماد و تداوم اجرای آن نهفته است.

ساختار پیشنهادی اجرای مداخله‌ها مبتنی بر حمایت همتایان

هدف از این چارچوب، ارائه مدل‌هایی ساده، قابل اجرا و منعطف برای حمایت روانی‌اجتماعی همتایان در شرایط بحران است. در این رویکرد، تأکید بر سادگی، داوطلبانه بودن، محرمانگی و تداوم است. این چارچوب به‌گونه‌ای طراحی شده که حتی در شرایط محدودیت منابع، فشار کاری بالا یا ناامنی اجتماعی هم قابل اجرا باشد. هدف، ایجاد ساختارهای پیچیده نیست؛ بلکه فراهم کردن فضایی ایمن، پایدار و قابل دسترس برای حمایت متقابل است.

حمایت همتایان در شرایط بحران می‌تواند به صورت فردی، یا گروهی اجرا شود. ضمن اینکه برنامه‌ها می‌توانند به‌صورت رسمی و تسهیل‌شده، یا در قالب گروه‌های خودگردان، و ارتباط فردی غیرساختاریافته اجرا شوند.

در سطح فردی، تمرکز بر ایجاد فضایی امن و قابل‌اعتماد برای بیان تجربه و تثبیت وضعیت هیجانی است. این نوع حمایت معمولاً کوتاه‌مدت، هدف‌مند و مبتنی بر کاهش شدت برانگیختگی و حفظ کارکرد روزمره است.

در سطح گروهی، هدف اصلی کاهش احساس انزوا، عادی‌سازی واکنش‌ها و بازسازی حس انسجام حرفه‌ای است. گروه می‌تواند فضایی فراهم کند که افراد دریابند در تجربه فشار و ابهام تنها نیستند و از طریق شنیدن روایت‌های مشابه، ظرفیت تحمل و معنا دادن به تجربه شخصی افزایش یابد.

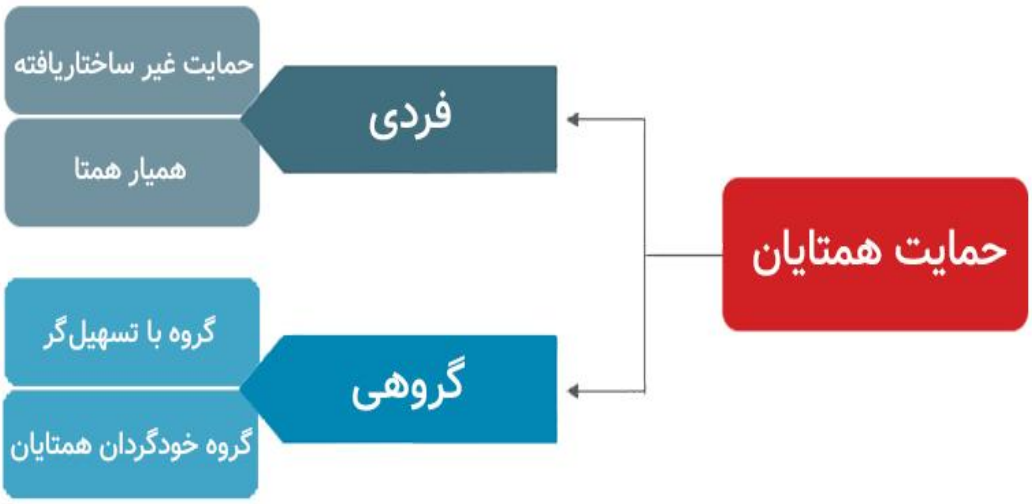
فعال‌سازی شبکه‌های درون سازمانی حمایت همتایان مکمل این دو سطح است. در این رویکرد، کارکنان با آموزش‌های کوتاه و ساختارمند می‌آموزند چگونه به شیوه‌ای ایمن، محترمانه و

غیرقضاوتی از یکدیگر حمایت کنند. این نوع حمایت، وابستگی به مداخله‌های تخصصی را کاهش داده و انسجام تیمی را تقویت می‌کند.

مدل‌های پیشنهادی برای حمایت از همتایان در ادامه ارایه شده و می‌تواند مبنای طراحی و اجرای برنامه‌های حمایتی در محیط‌های درمانی قرار گیرد.

اجرای عملی در سطوح مختلف

متخصصان حیطه سلامت روان می‌توانند بسته به ساختار سازمانی محل خدمت خود، با هماهنگی



مسوولان، اجرای یک یا چند مدل حمایتی زیر را تسهیل کنند.

یک حمایت فردی غیرساختاریافته

ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین نقطه آغاز، تشویق و تسهیل اجرای حمایت غیرساختاریافته همتایان از یکدیگر است. آموزش کمک‌های اولیه روان‌شناختی (به بخش کمک‌های اولیه روان‌شناختی مراجعه کنید) به کادر درمان و تشویق آن‌ها برای به‌کارگیری این مهارت به صورت روزمره و در حمایت از حلقه همتایان‌شان نقطه شروعی برای ایجاد محیط کار حمایتی است.

نقش متخصص سلامت روان در اجرا

- حمایت‌طلبی از مسوولان مرکز برای اجرای برنامه آموزشی
- آموزش کمک‌های اولیه روان‌شناختی به گروه‌های مختلف مرکز بهداشتی یا درمانی

- تشویق و حمایت کارکنان برای به‌کارگیری مهارت و حمایت از یکدیگر و پاسخ‌گویی به پرسش‌های آن‌ها
- مدیریت برنامه (شامل ثبت و گزارش آمار اجرا، دستاوردها و چالش‌ها)

دو مدل همیار همتا[1]

در این مدل، دو همکار با توافق متقابل با یکدیگر همراه می‌شوند و به‌صورت منظم، روزانه یا هفتگی بسته به شرایط، گفت‌وگویی کوتاه در حدود ۱۰ تا ۲۰ دقیقه برقرار می‌کنند. محور این گفت‌وگو تمرکز بر حال شخصی هر یک در مواجهه با شرایط بحران است، نه صرفاً مسائل حرفه‌ای یا بالینی. هدف، ایجاد فضایی امن برای بیان تجربه، بازتاب متقابل و کاهش احساس انزواست. در صورتی که یکی از دو نفر نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از فرسودگی شدید، اختلال عملکرد یا آسیب جدی مشاهده کند، مسئولیت دارد همتای خود را به دریافت کمک حرفه‌ای هدایت کند. این مدل به‌دلیل سادگی، انعطاف‌پذیری و نیاز حداقلی به منابع، برای محیط‌های پراسترس و کم‌امکانات، گزینه‌ای بسیار مناسب و عملی است.

نقش متخصص سلامت روان در اجرا

- حمایت‌طلبی از مسوولان مرکز برای اجرای برنامه
- فرخوان افراد داوطلب برای شرکت در برنامه
- آموزش کمک‌های اولیه روان‌شناختی و مدل همیار همتا
- تشویق و حمایت کارکنان برای به‌کارگیری مدل و حمایت از یکدیگر و پاسخ‌گویی به پرسش‌های آن‌ها
- مدیریت برنامه (شامل ثبت و گزارش آمار اجرا، دستاوردها و چالش‌ها)

سه گروه حمایتی با تسهیل‌گر

در این مدل گروه متشکل از ۴ تا ۱۲ نفر شرکت‌کننده و یک یا دو تسهیل‌گر آموزش‌دیده، هر هفته یا با فاصله بیشتر یا کمتر بسته به شرایط، جلسه‌ای ۴۵ تا ۹۰ دقیقه‌ای برگزار کنند. این گروه‌ها

[1] Peer Buddy System

می‌تواند از اعضای یک بخش تشکیل شود (مانند کارکنان بخش اورژانس)، در یک شیفت اجرا شود (مانند کارکنان شیفت شب بخش کودکان)، یا از افراد با نقش یکسان در بخش‌های مختلف تشکیل شود (مانند مددکاران یک بیمارستان).
این جلسات بهتر است ساختاری روشن داشته باشند (برای نمونه یک مدل ساختار گروه حمایتی در ادامه آمده است). تأکید می‌شود که این جلسات گروه‌درمانی نیستند و وارد تحلیل عمیق روان‌شناختی یا مداخله‌های تخصصی نمی‌شوند، بلکه هدف آن‌ها ایجاد فضایی ایمن برای حمایت متقابل و تقویت پیوند حرفه‌ای است.

ساختار پیشنهادی جلسات گروهی حمایتی

آغاز جلسه

جلسه با بیانی کوتاه و روشن آغاز می‌شود:

«هدف این جلسه ایجاد فضایی برای حمایت حرفه‌ای و انسانی است. مشارکت کاملاً داوطلبانه است و هیچ‌کس ملزم به بیان تجربه‌های شخصی نیست. تمرکز ما بر مدیریت تنش و حمایت از یکدیگر است.»

در ابتدای جلسه لازم است قوانین پایه توضیح داده شود:

- محرمانگی، عدم ثبت اطلاعات و ممنوعیت ضبط جلسه
- عدم قضاوت
- تمرکز بر تجربه شخصی، نه تحلیل سیاسی یا حرفه‌ای
- داوطلبانه بودن مشارکت
- یادآوری خطرات احتمالی ارتباط دیجیتال (در صورت برگزاری آنلاین)

گفتگوی هدایت‌شده

«هدف این گفت‌وگو تسهیل فهم تجربه، تنظیم هیجانی و کاهش احساس تنهایی است، نه تحلیل نظری یا بحث سیاسی.»

نمونه پرسش‌ها برای هدایت گفتگو:

- این روزها کدام تجربه برای شما دشوارتر بوده است؟
- فشار را بیشتر در کدام زمینه احساس می‌کنید: جسمی، هیجانی یا حرفه‌ای؟
- چه چیزی به شما کمک کرده در نقش خود باقی بمانید؟
- آیا میان وظیفه حرفه‌ای و شرایطی که در آن کار می کنید تعارضی احساس کرده‌اید؟
- به نظر شما در تجربه بحران چه چیزهایی در اختیار شما بوده و چه چیزهایی از کنترل شما خارج شده است؟

جمع‌بندی و آیین پایانی

در پایان جلسه می‌توان از شرکت‌کنندگان خواست:

- یک کلمه درباره وضعیت فعلی خود بیان کنند.
- یک اقدام کوچک مراقبتی برای هفته آینده مشخص کنند.

جلسه باید زمان‌مند بوده و پایان مشخص داشته باشد. آیین‌های کوتاه پایانی (خواندن یک شعر، دست‌زدن، بیان آرزوی واحد و ...) به انسجام گروهی کمک می‌کند.

نقش اجرایی متخصص سلامت روان در اجرا

- حمایت‌طلبی از مسوولان مرکز برای اجرای برنامه
- فرخوان افراد، گروه‌ها، یا بخش‌های داوطلب برای شرکت در برنامه
- برقراری تماس با افراد تاثیرگذار، گروه‌ها، یا بخش‌ها و جلب مشارکت آن‌ها برای شرکت کارکنان در برنامه
- تشویق و حمایت کارکنان برای شرکت در گروه‌ها
- مدیریت برنامه (شامل ثبت و گزارش آمار اجرا، دستاوردها و چالش‌ها)

چهار گروه خودگردان همتایان

در صورت فراهم بودن شرایط، می‌توان گروه‌های کوچکی متشکل از ۴ تا ۸ نفر تشکیل داد که هر هفته یا با فاصله بیشتر یا کمتر بسته به شرایط، جلسه‌ای ۳۰ تا ۴۵ دقیقه‌ای برگزار کنند. این گروه‌ها می‌تواند از اعضای یک بخش تشکیل شود (مانند کارکنان بخش اورژانس)، در یک شیفت اجرا شود (مانند کارکنان شیفت شب بخش کودکان)، یا از افراد با نقش یکسان در بخش‌های مختلف تشکیل شود (مانند مددکاران یک بیمارستان).
این جلسات بهتر است ساختاری روشن داشته باشند. به‌عنوان نمونه، هر نفر می‌تواند حدود ۳ تا ۵ دقیقه درباره وضعیت فعلی خود و تجربه‌اش در مواجهه با فشارهای اخیر صحبت کند و سایر اعضا بدون ورود به تحلیل یا ارایه توصیه، تنها بازتابی کوتاه و هم‌دلانه ارایه دهند. تأکید می‌شود که این جلسات درمان گروهی نیستند و وارد تحلیل عمیق روان‌شناختی یا مداخلات تخصصی نمی‌شوند، بلکه هدف آن‌ها ایجاد فضایی ایمن برای حمایت متقابل و تقویت پیوند حرفه‌ای است.

نقش متخصص سلامت روان در اجرا

- حمایت‌طلبی از مسوولان مرکز برای اجرای برنامه
- فرخوان افراد، گروه‌ها، یا بخش‌های داوطلب برای شرکت در برنامه
- برقراری تماس با افراد تاثیرگذار، گروه‌ها، یا بخش‌ها و جلب مشارکت آن‌ها برای اجرای برنامه
- آموزش کمک‌های اولیه روان‌شناختی و مدل حمایت گروهی همتایان
- تشویق و حمایت کارکنان برای اجرا و شرکت در گروه‌ها
- مدیریت برنامه (شامل ثبت و گزارش آمار اجرا، دستاوردها و چالش‌ها)

چالش‌ها و موانع اجرای برنامه‌های حمایت همتایان

اجرای برنامه‌های حمایت همتایان و جلسه‌های حمایتی، هرچند از نظر ساختاری ساده به نظر می‌رسد، در عمل با چالش‌هایی همراه است. در سطح فردی، برخی کارکنان ممکن است به دلیل

شرم، نگرانی از قضاوت، خستگی مفرط یا علائم افسردگی و بی‌حسی هیجانی تمایل یا آمادگی مشارکت نداشته باشند. تفاوت‌های شخصیتی، سبک‌های سازگاری متفاوت و تعارض‌های پنهان میان همکاران نیز می‌تواند بر کیفیت گفت‌وگو اثر بگذارد. در سطح محیطی، فشار کاری بالا، کمبود زمان، نبود فضای خصوصی و نگرانی‌های امنیتی از جمله موانع رایج هستند. افزون بر این، ابهام در حدود حرفه‌ای، یا ترس از افشای ناخواسته اطلاعات ممکن است مشارکت را کاهش دهد. مهم است که این چالش‌ها از قبل پیش‌بینی شوند و برنامه با انعطاف و واقع‌بینی طراحی شود، نه با انتظار مشارکت کامل و بی‌نقص از ابتدا.

هم‌چنین ممکن است برخی افراد نقش این جلسات را با روان‌درمانی اشتباه بگیرند یا انتظار مداخله تخصصی داشته باشند، در حالی که هدف اصلی این ساختار، حمایت متقابل و تنظیم هیجانی اولیه است. اگر مرزها روشن نباشد، خطر ارائه توصیه‌های درمانی نامتناسب، فعال‌شدن تعارض‌های قدیمی یا حتی بازفعال‌سازی هیجانی بدون حمایت کافی وجود دارد. بنابراین شفافیت در هدف، چارچوب و حدود مداخله، پیش‌شرط موفقیت برنامه است.

در برخی شرایط، حضور یک تسهیل‌گر می‌تواند به حفظ ساختار، مدیریت زمان، تنظیم تعارض‌ها و اطمینان از مشارکت متوازن اعضای گروه کمک کند. تسهیل‌گر، نقش درمانگر را ایفا نمی‌کند، بلکه مسئول حفظ چارچوب ایمن گفت‌وگو است.

متخصصان سلامت روانی که این نقش را بر عهده می‌گیرند، باید آمادگی لازم برای گوش‌دادن فعال، مدیریت پویایی‌های گروهی، تنظیم برانگیختگی هیجانی و تعیین مرز (مانند مشخص کردن مواردی که می‌توان در مورد آن‌ها در گروه گفت‌وگو کرد و مواردی که خارج از هدف گروه است) را داشته باشند. آشنایی با اصول حمایت مبتنی بر تروما، توانایی مداخله حداقلی در تعارض‌ها و تشخیص موارد نیازمند ارجاع تخصصی، از مهارت‌های ضروری برای ایفای این نقش محسوب می‌شود.

بخش دوم

کمک‌های اولیه روان‌شناختی

کمک‌های اولیه روان‌شناختی[۲]

کمک‌های اولیه روان‌شناختی رویکردی کوتاه‌مدت، عملی و مبتنی بر شواهد برای حمایت از افرادی است که در معرض بحران، خشونت یا فشار شدید روانی قرار گرفته‌اند. این مداخله بر سه اصل اساسی «دیدن، شنیدن و وصل کردن» استوار است: نخست مشاهده و شناسایی نشانه‌های آشفتگی یا نیاز فوری، سپس گوش دادن فعال و بدون قضاوت و در نهایت تسهیل ارتباط فرد با منابع حمایتی، دادن اطلاعات درست و دقیق و شبکه‌های خدماتی ایمن. هدف کمک‌های اولیه روان‌شناختی درمان یا تحلیل عمیق تجربه آسیب نیست، بلکه تثبیت نسبی وضعیت روانی، کاهش احساس تنهایی و تقویت احساس امنیت و کارآمدی در کوتاه‌مدت است. این رویکرد به‌ویژه در شرایط ناامنی و فشار جمعی، ابزاری عملی و قابل‌اجرا برای محیط‌های درمانی به شمار می‌آید.

انتظار می‌رود متخصصان سلامت روان، این مهارت را به گروه‌های مختلف کارکنان مراکز بهداشتی یا درمانی ـ از جمله نیروهای درمانی، پشتیبانی، اجرایی و کارکنان غیردرمانی ـ آموزش دهند تا آنان بتوانند در چارچوبی ساده و ایمن از همتایان خود حمایت کنند. آموزش این اصول به تقویت شبکه‌های درونی حمایت، کاهش انزوای هیجانی و افزایش حس همبستگی حرفه‌ای کمک می‌کند و وابستگی به مداخلات تخصصی را در موقعیت‌های غیرحاد کاهش می‌دهد.

راهنمای کاربردی کمک‌های اولیه روان‌شناختی

کمک‌های اولیه روان‌شناختی یک روش ساده و عملی است که می‌تواند توسط کارکنان غیرمتخصص نیز استفاده شود و بر حمایت انسانی و عملی تمرکز دارد. به عبارتی در این روش «ما درمان نمی‌کنیم، ما همراهی می‌کنیم».

کمک‌های اولیه روان‌شناختی چیست؟

[۲] Psychological first aid

- حمایت انسانی، محترمانه و عملی
- کمک به افراد دچار استرس برای:

  - ایمنی و احساس امنیت: کاهش خطرات محیطی و روان‌شناختی
  - آرام‌سازی:کمک به کاهش اضطراب و آشفتگی
  - ارتباط برای دسترسی به حمایت و خدمات: تقویت ارتباط با همکاران و خانواده، و استفاده از حمایت و خدمات در دسترس
  - کارآمدی: کمک به احساس توانمندی و کنترل
  - امید: تقویت نگاه مثبت به آینده

کمک‌های اولیه روان‌شناختی چه نیست؟

- روان‌درمانی
- تشخیص یا برچسب‌گذاری
- بازگویی اجباری حادثه یا مشکل
- حل کامل مشکلات

این چارچوب بر سه اصل ساده استوار است :**دیدن، گوش دادن و برقراری ارتباط.**



۱ ببین

منظور از دیدن توجه به تغییرات رفتاری، نشانه‌های آشفتگی، انزوا، گریه مکرر، تحریک‌پذیری یا سردرگمی است. هدف مشاهده حمایتی و ارزیابی سریع وضعیت است نه قضاوت یا برچسب‌زدن. در هر زمانی می‌توان با توجه به اطرافیان در محل کار این مهارت را به کار برد، بین شیفت‌ها، بعد از یک حادثه شدید، هنگام خستگی یا خطای کاری یا در زمان استراحت کوتاه که فرصت بیشتری وجود دارد.

مثال:

- آیا محیط امن است؟
- چه کسی نیاز فوری دارد؟
- چه کسی شدیداً مضطرب است؟

۲ گوش کن

هدف درک نیازها بدون فشار است. اگر فرد تمایل به صحبت دارد، با حضور کامل و بدون قضاوت گوش دهید. نیازی به تحلیل، نصیحت یا پیدا کردن راه‌حل فوری نیست.

مثال:

- *حالت چطوره؟*
- *الان چی بیشتر اذیتت می‌کنه؟*
- *خیلی فشار بوده، می‌خوای چند دقیقه استراحت کنیم و حرف بزنیم؟*
- *اخیرا کم حرف شدی، می‌تونی برام بگی چی شده؟*
- *کاملاً قابل درکه که این شرایط سخت باشه.*

۳ وصل کن

هدف وصل کردن فرد به منابع حمایتی است. پس از خوب گوش دادن به فرد، در صورت نیاز او را به منابع حمایتی متصل کنید؛ مانند سرپرست، همکار مورد اعتماد، مشاور سازمان یا خدمات تخصصی. هم‌چنین اطلاعات را شفاف، دقیق و قابل اعتماد منتقل کنید تا از شایعات و ایجاد اضطراب غیرضروری کاسته شود.

مثال:

- می‌خوای با یکی از بچه‌ها صحبت کنیم شیفت بعدی‌ات را عوض کنی؟
- کمکت کنم یه کم کارهات را سبک‌تر کنیم؟
- فکر می‌کنی اگر با روانپزشک مرکز صحبت کنی کمکی بکنه؟

نکات مهم

- هدف کاهش فشار در لحظه است نه حل کامل مشکل.
- شنونده خوبی باشید اما فرد را مجبور به صحبت درباره تجربه‌های دردناک نکنید.
- محرمانگی را رعایت کنید، مگر در موارد خطر جدی مانند خطر آسیب به خود. در مورد گفتگویی که داشتید با سایر همکاران صحبت نکنید.
- در صورت مشاهده نشانه‌های شدید مانند افکار خودکشی، مصرف مواد، افت عملکرد شدید فرد را به خدمات تخصصی ارجاع دهید. این کار را با مشارکت خود فرد و در صورت نیاز با کمک گرفتن از همکار یا مسئولی که فرد به وی اعتماد دارد انجام دهید.

برای مطالعه بیشتر در این مورد به سناریوهای تمرینی در پیوست رجوع کنید.

ملاحظات فرهنگی در ایران

در آموزش به کارکنان سلامت به این موارد توجه کنید:



بخش سوم

بحران و تروما

فرهنگ بحران

بحران‌ها رویدادهایی صرفاً طبیعی، روانشناختی، اجتماعی یا سیاسی نیستند، بلکه باید آن‌ها را پدیده‌هایی دانست که معنا، تجربه و پاسخ به آن‌ها در بستر «فرهنگ» شکل می‌گیرد. فرهنگ بحران، مجموعه ارزش‌ها، هنجارها، باورها و روایت‌هایی است که تجربه فردی و جمعی از فجایع را تعیین می‌کند و رفتارهای اجتماعی و پاسخ‌های رسمی و حاکمیتی را سازمان‌دهی می‌نماید. این دیدگاهِ مفهومی فضای نظری مداخلات بالینی و روان‌شناختی را شکل می‌دهد و امکان هم‌سویی فرهنگی در طراحی مداخلات پیشگیرانه و واکنشی و نیز بازسازی اجتماعی را افزایش می‌دهد.

آمادگی ذهنی و عملی

یکی از مفاهیم کلیدی فرهنگ بحران، آمادگی ذهنی و عملی مردم و مسوولان است. در برخی موارد، افراد و سازمان‌ها بحران را انکار می‌کنند، کم‌اهمیت جلوه می‌دهند و به شکل واکنش نمایشی یا شعاری با آن مواجه می‌شوند. اما برخی جوامع و نهادها دارای تجربه، آموزش و منابع کافی برای واکنش مؤثر هستند. سطح آمادگی ذهنی و عملی، تعیین‌کننده سرعت و اثربخشی پاسخ، مدیریت هیجانات جمعی و کاهش آسیب روانی است.

بنابراین، برای هر مرکز یا سازمان، باید ارزیابی شود که مردم و کارکنان تا چه حد:

۱. اطلاعات و مهارت لازم برای مواجهه با بحران دارند،
۲. از نظر روانی آماده پذیرش واقعیت‌های تهدیدآمیز هستند،
۳. از منابع و امکانات کافی برای واکنش سریع برخوردارند.

بهره‌گیری از فرهنگ بحران

هنجارها و ارزش‌های فرهنگی، شیوه معمول بیان هیجان، سوگواری جمعی، مشارکت اجتماعی و اعتماد به نهادها را تعیین می‌کنند. به همین ترتیب، چارچوب‌های معنایی جامعه، تجربه بحران را قابل فهم و قابل پیش‌بینی می‌کنند و واکنش‌های ناهنجار را مانع می‌شوند.

بحران از نظر فرهنگی یک تجربه معناپرداز است. چیزی که یک جامعه آن را بحران می‌نامد، در بستر فرهنگی دیگر ممکن است امری عادی یا حتی فرصتی برای بازسازی تلقی شود. فرهنگ به ما نشان می‌دهد که چه چیزی بحران است، چگونه درباره آن سخن گفته شود، پیش از بحران چه نگاه و رفتاری قابل قبول است و پس از آن چه واکنش‌هایی متناسب یا نامناسب است. روایت‌های فرهنگی و داستان‌ها و نمادهای بحران‌های گذشته، حافظه و تجربه جمعی را می‌سازند و مسیر کنش‌ها و واکنش‌های آینده را تحت تأثیر قرار می‌دهند. آموزش، اطلاع‌رسانی و طراحی خدمات حمایتی و مداخله در بحران، باید با روایت‌های غالب جامعه همسو باشد تا احساس امنیت و مشارکت افزایش یابد.

جمع‌بندی

فرهنگ بحران به ما یادآوری می‌کند که بحران رویدادی صرفاً مربوط به دیگران تلقی نمی‌شود و ایجاد آمادگی برای آن باید بخشی از فرهنگ عمومی مردم باشد. از طرفی بحران صرفاً رویدادی آسیب‌زا نیست، بلکه تجربه‌ای معناپرداز و روانی/ اجتماعی/ فرهنگی است.

برای طراحی مداخلات مؤثر باید:

۱.پیش از طراحی هر مداخله، الگوهای فرهنگی، ارزش‌ها و هنجارهای جامعه هدف شناسایی شوند.

۲. پیام‌ها و آموزش‌ها باید با زبان، نمادها و چارچوب‌های فرهنگی قابل فهم باشند.

۳. تمرین‌های شبیه‌سازی بحران، آموزش پاسخ سریع و سنجش منابع موجود، باید در برنامه‌های رسمی قرار گیرد.

٤. از ظرفیت‌های خانواده، گروه‌های محلی و نهادهای اجتماعی برای تقویت تاب‌آوری جمعی استفاده شود.

۵. پس از هر بحران، برای بازسازی فرهنگی/ اجتماعی اقدام و جهت ارتقای آمادگی آینده، تجربه‌ها و بازخوردها ثبت و تحلیل شود.

مبانی نظری و مفهومی

تروما چیست؟

تروما تجربه‌ای جسمی/ روانی است که ظرفیت فرد برای تنظیم هیجان، احساس امنیت و معنا دادن به تجربه را مختل می‌کند. تروما زمانی رخ می‌دهد که فرد احساس کند در خطر است، کنترلی ندارد و آینده قابل پیش‌بینی نیست. شدت رویداد به‌تنهایی تعیین‌کننده بروز تروما نیست؛ آنچه تعیین‌کننده است تجربه درونیِ درماندگی و ناامنی است.

در بحران‌های جمعی، تروما پایان مشخصی ندارد، بارها فعال می‌شود و اغلب فرصت پردازش پیدا نمی‌کند. در نتیجه، سیستم عصبی در حالت هشدار باقی می‌ماند و انتظار بازگشت سریع به وضعیت عادی واقع‌بینانه نیست. درمانگر نیز در همین بستر زندگی می‌کند. کاهش تمرکز، تحریک‌پذیری، خستگی یا بی‌حسی هیجانی در درمانگر نشانه ضعف نیست، بلکه واکنشی طبیعی به شرایطی غیرطبیعی است.

ترومای جمعی و پیامدهای آن

ترومای جمعی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن یک جامعه یا گروه بزرگ انسانی با رویدادهایی مواجه می‌شود که به‌صورت گسترده احساس امنیت، عدالت و پیش‌بینی‌پذیری را مختل می‌کند. در چنین شرایطی، آسیب صرفاً تجربه‌ای فردی نیست، بلکه به بافت اجتماعی نفوذ می‌کند و روابط، اعتماد و معنای مشترک را تحت تأثیر قرار می‌دهد. پیامدهای ترومای جمعی اغلب در سطوح فردی، بین‌فردی و نهادی به‌طور هم‌زمان ظاهر شده و هر یک بر دیگری تأثیر عمیقی دارد.

کارکنان نظام سلامت نیز در این بستر ممکن است:

- شاهد خشونت مستقیم یا پیامدهای جسمی و روانی آن باشند؛
- به‌طور مستمر با بیماران آسیب‌دیده و خانواده‌های سوگوار مواجه شوند؛

- در محیط کار خود احساس ناامنی، بی‌اعتمادی یا فشار ساختاری را تجربه کنند.

ترومای جمعی می‌تواند به‌تدریج اعتماد به نهادها، انسجام حرفه‌ای و حتی معنای خدمت درمانی ارائه شده را دگرگون کند. در چنین شرایطی، بازشناسی این پدیده و درک اثرات آن، گامی اساسی در طراحی مداخلات حمایتی مؤثر به شمار می‌آید.

ترومای مشترک[۳]

ترومای مشترک وضعیتی است که در آن درمانگر و مراجع به‌طور هم‌زمان در معرض یک رویداد آسیب‌زا قرار دارند و این هم‌زمانی می‌تواند بر فرایند درمان، مرزهای حرفه‌ای و تنظیم هیجانی تأثیر بگذارد. برخلاف ترومای نیابتی که از مواجهه با روایت آسیب دیگران شکل می‌گیرد، در ترومای مشترک خود درمانگر نیز مستقیماً در همان بستر ناامن زندگی می‌کند. این هم‌زمانی آسیب می‌تواند ظرفیت همدلی را افزایش دهد و درک عمیق‌تری از تجربه زیسته مراجعان فراهم آورد؛ اما در عین حال، خطر فرسودگی، درهم‌تنیدگی هیجانی و تضعیف مرزهای حرفه‌ای را نیز افزایش می‌دهد. از این رو، خودآگاهی مستمر درمانگر، توجه به وضعیت هیجانی شخصی و مراقبت از مرزهای حرفه‌ای، بخش جدایی‌ناپذیر کار حمایتی در چنین بسترهایی است.

استرس ثانویه و ترومای نیابتی[۴]

مواجهه مکرر با روایت‌های خشونت، آسیب جسمی، فقدان یا رنج شدید انسانی می‌تواند به شکل‌گیری واکنش‌هایی منجر شود که گاه با نشانه‌های اختلال استرس پس از سانحه هم‌پوشانی دارند. از جمله این واکنش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

[۳] Shared trauma
[۴] vicarious trauma

- تصاویر مزاحم ذهنی
- بی‌حسی یا کرختی هیجانی
- تحریک‌پذیری و کاهش آستانه تحمل
- اختلال خواب
- کاهش تمرکز و کارآمدی

در بسیاری از موارد، این واکنش‌ها بیانگر پاسخ طبیعی سیستم عصبی به فشار روانی هستند و لزوماً نشانه آسیب روان‌پزشکی نیستند. نگاه غیرآسیب‌انگارانه و عادی‌سازی این تجربه‌ها، گام نخست در پیشگیری از تشدید علائم و تقویت ظرفیت تنظیم است. استرس ثانویه معمولاً به بروز علائم اضطرابی یا وابسته به تروما در اثر مواجهه مکرر با روایت‌های آسیب اشاره دارد، در حالی‌که ترومای نیابتی بیشتر به تغییر تدریجی در باورها، احساس امنیت و جهان‌بینی درمانگر مربوط می‌شود. بنابراین، برخلاف ترومای مشترک که ناشی از تجربه هم‌زمان یک بحران مشترک است، استرس ثانویه و ترومای نیابتی حتی در غیاب تجربه مستقیم رویداد نیز می‌توانند رخ دهند.

آسیب اخلاقی[۵]

آسیب اخلاقی زمانی شکل می‌گیرد که فرد احساس کند نتوانسته مطابق ارزش‌های حرفه‌ای یا انسانی خود عمل کند، یا شاهد اقداماتی بوده که با اصول بنیادین او در تعارض است. این وضعیت ممکن است در نتیجه اقدام، اجبار به اقدام، یا ناتوانی در جلوگیری از یک پیامد آسیب‌زا شکل گیرد. برخلاف اختلالات مبتنی بر ترس، هسته اصلی آسیب اخلاقی تجربه شرم، گناه یا احساس خیانت به ارزش‌های اساسی خود است. در محیط‌های درمانی با محدودیت منابع یا فشارهای ساختاری یا سیاسی، این تجربه می‌تواند پررنگ‌تر و پیچیده‌تر شود.

نشانه‌های رایج آسیب اخلاقی عبارت‌اند از:

- احساس شرم یا گناه پایدار
- خشم نسبت به ساختارها یا تصمیم‌گیرندگان
- حس درماندگی و بی‌اختیاری
- تردید در هویت یا فرسایش معنای فعالیت حرفه‌ای

[۵] moral injury

پرداختن به آسیب اخلاقی نیازمند فضایی امن و غیرقضاوتی است که در آن فرد بتواند تعارض‌های درونی خود را بیان کند و میان مسئولیت شخصی و محدودیت‌های بیرونی تمایز قائل شود.

تاب‌آوری[۶]

تاب‌آوری توانایی حفظ پیوند، معنا و کارکرد حرفه‌ای در دل بی‌ثباتی است و به معنای سازگاری خلاقانه با شرایط تغییر یافته تعریف می‌شود. بر این اساس، تاب‌آوری به معنای بی‌تفاوتی، انکار رنج یا سازگاری منفعلانه نیست و از طرفی صرفاً بازگشت به وضعیت پیشین محسوب نمی‌شود.

تاب‌آوری صرفاً مسئولیت فردی نیست و در سطح سازمانی نیز نیازمند فرهنگ حمایتی، توزیع عادلانه بار کاری و به رسمیت شناختن رنج کارکنان است. بنابراین تاب‌آوری فرآیندی پویا و اغلب جمعی است که در بستر روابط تقویت می‌شود.

پژوهش‌ها نشان می‌دهند که عوامل زیر در تقویت تاب‌آوری نقش اساسی دارند:

- ارتباط اجتماعی معنادار و حمایت
- امکان روایت‌گری و معنا دادن به تجربه‌ها
- احساس کارآمدی و تأثیرگذاری حرفه‌ای
- آیین‌های جمعی و مناسک کوچک در محیط کار
- تنظیم آگاهانه و مستمر سیستم عصبی خودکار یا خودتنظیمی هیجانی (تنفس عمیق، ذهن‌آگاهی و ...)

تقویت این عوامل نه‌تنها از فرسودگی پیشگیری می‌کند، بلکه زمینه بازسازی اعتماد و انسجام حرفه‌ای را نیز فراهم می‌آورد.

مراقبت و مداخلات آگاه به تروما[۷]

«مراقبت آگاه به تروما» بر این پیش‌فرض استوار است که بسیاری از مراجعان، حتی اگر تجربه‌های آسیب‌زا را به‌صراحت بیان نکنند، ممکن است در معرض تهدید یا فقدان قرار گرفته باشند. از این‌رو، محیط بالینی و شیوه تعامل حرفه‌ای باید به‌گونه‌ای باشد که احتمال بازتجربه احساس ناایمنی، تحقیر یا بی‌اختیاری را کاهش دهد. تمامی مداخلات باید بر سه اصل بنیادین استوار

[۶] resilience
[۷] trauma-informed care

باشند: *امنیت، احترام و کرامت*. این اصول تأکید می‌کنند که فرد در هر مرحله از دریافت خدمات باید احساس امنیت نسبی داشته باشد، بدون قضاوت شنیده شود، و شأن و کرامت انسانی او در تمامی تعاملات حفظ شود. این سه اصل نه صرفاً ارزش‌های اخلاقی، بلکه پیش‌شرط‌های مداخله مؤثر در شرایط بحران هستند.

در بحران‌ها و تروماهای جمعی، کیفیت خدمات حمایتی تنها به نوع مداخله بالینی وابسته نیست، بلکه به فضایی که در آن خدمت ارائه می‌شود نیز ارتباط دارد. «مراقبت آگاه به تروما» بر این پیش‌فرض استوار است که بسیاری از مراجعان، حتی اگر تجربه‌های آسیب‌زا را به‌صراحت بیان نکنند، ممکن است در معرض تهدید یا فقدان قرار گرفته باشند. از این‌رو، محیط بالینی و شیوه تعامل حرفه‌ای باید به‌گونه‌ای باشد که احتمال بازتجربه‌ی احساس ناایمنی، تحقیر یا بی‌اختیاری را کاهش دهد.

این رویکرد، یک درمان تخصصی برای تروما محسوب نمی‌شود. از طرفی، هدف آن ورود مستقیم به خاطرات آسیب‌زا یا پردازش آن‌ها نیست، بلکه فراهم کردن بستری است که در آن فرد بتواند با احساس نسبی امنیت، احترام و امکان انتخاب حضور یابد. در شرایطی که بحران هم‌چنان فعال یا منابع محدود است، چنین رویکردی می‌تواند مقدمه‌ای ضروری برای هر مداخله درمانی عمیق‌تر باشد.

در این چارچوب «امنیت» مفهومی محوری است؛ امنیت نه فقط به معنای نبود خطر عینی، بلکه به‌عنوان تجربه‌ای درونی از پیش‌بینی‌پذیری، وضوح و عدم قضاوت. توضیح روشن درباره هدف جلسات، حدود محرمانگی، نقش درمانگر و روند کار، می‌تواند از شدت ابهام بکاهد و به کاهش تنش و برانگیختگی کمک کند. در فضای بحران، که بی‌ثباتی و اخبار متناقض فراوان است، همین میزان از شفافیت کارکردی آرامش‌بخش دارد.

توجه به «انتخاب فرد» نیز اهمیت دارد. تجربه‌های آسیب‌زا غالباً با احساس از دست رفتن کنترل همراه‌اند. فراهم آوردن امکان مکث، تغییر موضوع، یا به تعویق انداختن پرداختن به برخی موضوعات، می‌تواند به بازسازی حس اختیار کمک کند. در جلسات گروهی نیز تأکید بر داوطلبانه بودن مشارکت و پرهیز از فشار برای بیان تجربه‌های شخصی، از افزایش ناخواسته تنش جلوگیری می‌کند.

مراقبت آگاه به تروما هم‌چنین بر «کیفیت رابطه حرفه‌ای» تأکید دارد. رابطه‌ای که در آن گفت‌وگو شفاف، نقش‌ها روشن، و همراهی با احترام متقابل است، کمتر احتمال دارد یادآور الگوهای قدرت نابرابر یا تجربه‌های آسیب‌زا باشد. تمرکز بر ظرفیت‌ها و منابع فرد که حتی در شرایط دشوار نیز باقی مانده است، می‌تواند از تثبیت احساس درماندگی پیشگیری کند.

این رویکرد تنها به سطح تعامل فردی محدود نمی‌شود. در سطح مرکز درمانی یا سازمان ارائه‌دهنده خدمت نیز، نحوه پذیرش مراجع، زبان به‌کاررفته در فرم‌ها، چگونگی اطلاع‌رسانی، و شیوه مدیریت تعارض‌ها می‌تواند تجربه‌ای حمایت‌کننده یا برعکس، تنش‌زا ایجاد کند. آموزش کارکنان درباره واکنش‌های طبیعی به تروما، توجه به فرسودگی حرفه‌ای و ایجاد سازوکارهای حمایتی برای تیم درمان، بخشی از تحقق عملی این رویکرد است. محیطی که برای کارکنان بی‌ثبات یا فرساینده باشد، به‌سختی می‌تواند برای مراجعان فضایی امن فراهم آورد.

در عمل نشانه‌هایی مانند افزایش ناگهانی تنش بدنی، سکوت طولانی، آشفتگی آشکار یا کناره‌گیری شدید می‌تواند حاکی از فعال‌شدن احساس تهدید باشد. در چنین مواقعی، اولویت با کاهش تنش و بازگرداندن احساس ثبات است، نه ادامه اصرار بر محتوا یا پیشبرد برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده.

در مجموع مراقبت آگاه به تروما چارچوبی است که پیشگیری از بازآسیب‌رسانی، حفظ کرامت انسانی و ایجاد حداقلی از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری را در کانون توجه قرار می‌دهد. در شرایط بحران‌های جمعی، چنین رویکردی نه افزوده‌ای تجملی، بلکه بخشی از مسئولیت حرفه‌ای در ارائه حمایت روان‌شناختی محسوب می‌شود.

مداخله و مراقبت مبتنی بر رویکرد آگاه به تروما، در بستر ناامنی و بحران‌های مداوم، مستلزم بازتعریف هدف درمان است: از پردازش عمیق تروما به ایجاد ایمنی نسبی و پیشگیری از آسیب بیشتر. در این رویکرد، درمانگر می‌پذیرد که خود او نیز همچون مراجع در معرض فشار مزمن قرار دارد و انتظار بازگشت سریع به حالت عادی واقع‌بینانه نیست. تمرکز مراقبت بر شناخت تأثیر تروما بر سیستم عصبی، عادی‌سازی واکنش‌های طبیعی به شرایط غیرعادی، تنظیم تدریجی برانگیختگی، محدود نگه‌داشتن دامنه مداخله، و پرهیز از بازفعال‌سازی ناخواسته خاطرات است. در این چارچوب، هدف جلسه نه مواجهه مستقیم با گذشته، بلکه تقویت احساس امنیت نسبی، افزایش ظرفیت تحمل هیجان، حفظ کارکرد حداقلی و فراهم کردن حضوری باثبات، محترمانه و غیرقضاوتگرانه است. راهنمای عملی اجرای مداخلات مبتنی بر تروما در ادامه ارائه شده است.

رویکردها و مداخلات کاربردی در تروما

کار با مراجعان آسیب دیده در بحران نیازمند خودآگاهی مستمر درمانگر است. پیش از پذیرش یا ادامه کار با چنین مراجعانی، لازم است درمانگر از خود بپرسد آیا می‌تواند بدون عجله گوش دهد، آیا قادر است هیجان شدید را تحمل کند بدون اینکه فوراً بخواهد آن را اصلاح کند، و آیا شرایط

ذهنی و جسمی‌اش به‌گونه‌ای است که بتواند جلسه را اداره کند. اگر روایت‌های مراجع موجب بازفعال شدن تروماهای درمانگر می‌شود، یا خشم، وحشت و بی‌خوابی تمرکز او را مختل کرده است، کاهش تعداد مراجعان، وقفه موقت، ارجاع یا دریافت سوپرویژن[۸] تصمیمی حرفه‌ای و اخلاقی است.

هدف جلسه در شرایط ناامن

در بحران فعال، هدف جلسه درمانی پردازش عمیق خاطرات تروماتیک، مواجهه مستقیم با گذشته یا معنا دادن کامل به رنج نیست. در این شرایط، هدف اصلی ایجاد حس نسبی امنیت، کاهش شدت برانگیختگی، پیشگیری از تشدید علائم و کمک به حفظ کارکرد حداقلی است. تثبیت شرایط روانی مراجع مقدم بر پردازش تروما است.

حفظ روزمرگی

در بحران ذهن به لنگر نیاز دارد. این لنگرها اغلب در قالب برنامه‌های روزمره ساده روزانه شکل می‌گیرند؛ مانند تنظیم زمان خواب و بیداری، تعریف یک تا سه کار کوچک و قابل انجام در روز، یا انجام فعالیت‌های دستی ساده مانند آشپزی، نوشتن یا تمیزکاری. این برنامه‌ها نباید سنگین یا تنبیهی باشند؛ بلکه باید ساده، قابل انجام و بی‌نیاز به انرژی زیاد باشند تا حس تداوم و کنترل نسبی را تقویت کنند.

نگرانی و اضطراب

نگرانی در بحران واکنشی طبیعی است. هدف درمان حذف نگرانی نیست، بلکه جلوگیری از گسترش آن به همه حوزه‌های زندگی است. هنگامی که اضطراب فعال می‌شود، درگیر کردن بدن از طریق فعالیت‌های دستی، تمرکز بر محرک‌های حسی، افزایش ارتباطات انسانی و درمیان گذاشتن تجربه با فردی امن می‌تواند به تنظیم هیجان منفی کمک کند.

[۸] supervision

در صورت بروز حمله عصبی، بازگرداندن توجه به محیط، انجام تنفس شمارشی و توضیح ماهیت گذرای این تجربه ضروری است. مراجع باید بداند که حمله عصبی گرچه بسیار ناراحت‌کننده است، اما معمولاً خطر جسمی فوری ایجاد نمی‌کند.

بی‌حسی و آپاتی

بی‌حسی هیجانی اغلب واکنش محافظتی سیستم عصبی در برابر فشار بیش‌ازحد است. در این حالت، تمرکز بر فعال‌سازی تدریجی و ملایم، مفیدتر از تلاش برای ایجاد هیجان شدید است. نوشتن روزانه، ثبت تجربه‌های ساده، افزایش تماس اجتماعی هر چند محدود، و تمرکز بر تجربه‌های حسی می‌تواند به خروج تدریجی از حالت خاموشی کمک کند.

اصول درمان شناختی رفتاری در بحران

واقعیت‌محوری به‌جای اطمینان‌بخشی

در درمان شناختی/رفتاری، به‌ویژه در شرایط بحران، تمرکز بر ارزیابی واقع‌بینانه است نه آرام‌سازی سطحی یا امیدبخشی کلی. در چنین موقعیتی درمانگر باید به مراجع کمک کند میان واقعیت، شایعه و فاجعه‌سازی تمایز بگذارد. استفاده از جملاتی مانند «همه‌چیز درست می‌شود» یا «نگران نباش» معمولاً کارکرد درمانی ندارد و حتی می‌تواند موجب بی‌اعتمادی به درمانگر شود. بنابراین بهتر است گفت‌وگو بر مواردی که واقعاً از آن‌ها اطلاع داریم، تفکیک این موارد از حدس و گمان، و کاهش بزرگ‌نمایی فاجعه‌آمیز متمرکز باشد.

بهداشت شناختی

در بحران، ذهن در معرض حجم بالایی از اطلاعات قرار می‌گیرد. بسیاری از محتواهای خبری حتی اگر بر مبنای واقعیت باشند به شکلی ارایه می‌شوند که بیش از اطلاع‌رسانی، خشم یا وحشت را

فعال می‌کنند. از این‌رو لازم است مفهوم بهداشت شناختی به مراجع آموزش داده شود؛ به این معنا که دریافت اخبار از منابعِ محدود و معتبر انجام شود، بررسی اخبار در زمان‌های مشخص صورت گیرد و از گشتن مداوم در شبکه‌های اجتماعی پرهیز شود. بار شناختی بالا، سیستم عصبی را در حالت برانگیختگی مزمن نگه می‌دارد و مانع تنظیم هیجانی می‌شود.

خطاهای شناختی در بحران

در شرایط بحران، برخی خطاهای شناختی شدت می‌گیرند. تعمیم افراطی باعث می‌شود فرد نتیجه بگیرد «همه‌چیز در حال فروپاشی است». هم‌آمیزی زمانی موجب می‌شود وضعیت فعلی به‌صورت «همیشگی» تجربه شود. بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی می‌تواند به این باور بی‌انجامد که «هیچ کاری فایده ندارد». استدلال هیجانی فرد را به این نتیجه می‌رساند که چون حالش بد است، پس واقعیت نیز کاملاً بد است. هم‌چنین نادیده گرفتن جنبه‌های مثبت باعث می‌شود هر تجربه خوشایندی به‌عنوان امری نامناسب یا گناه‌آلود تلقی شود.

در چنین شرایطی هدف درمانگر اصلاح کامل این باورها نیست، بلکه ایجاد فاصله شناختی ملایم از جزییات بحران و کمک به واقعیت‌سنجی تدریجی است.

اصول درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد[۹] در بحران

در بحران، تکنیک‌ها و اصول «درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد» به‌منظور بهتر کردن فوری حال مراجع به‌کار نمی‌رود، بلکه برای افزایش انعطاف‌پذیری روانی و ظرفیت ادامه زندگی با حال بد استفاده می‌شود.

پذیرش

پذیرش یعنی توقف جنگ بی‌ثمر با تجربه درونی؛ نه دوست داشتن آن و نه تسلیم شدن.

«اگر مضطربی، آیا می‌توانیم بدون جنگیدن با اضطراب، کمی فضا ایجاد کنیم؟»

[۹] acceptance and commitment therapy

فاصله‌سازی شناختی

به معنای گذر از محتوای فکر به فرآیند آن است. هدف قانع کردن نیست؛ فاصله‌سازی است.

«من دارم فکر می‌کنم که...»

تماس با لحظه حال

با تمرکز حسی ساده، کوتاه و اختیاری انجام می‌شود و البته مبتنی بر مراقبه[۱۰] نیست. این روش به خروج از غرق‌شدگی ذهنی کمک می‌کند.

تمرکز بر ارزش‌ها در شرایط عدم‌قطعیت

تمرکز بر ارزش‌ها، به‌ویژه در زمانی که آینده مبهم است، فرآیندها و جهت‌گیری را مشخص می‌کند. هدف‌ها ممکن است از بین بروند اما ارزش‌ها باقی می‌مانند.

«در این شرایط سخت، می‌خواهی چه جور انسانی باشی؟»

اقدام متعهدانه

به شکل گام‌های کوچک و واقعی برای امروز تعریف می‌شود، نه تغییر بزرگ و آینده‌محور.

[۱۰] meditation

آنچه درمان مبتنی بر تروما نیست

درمان در بحران به معنای انکار واقعیت، مثبت‌گرایی افراطی، اجبار به تمرکز بر جنبه‌های مثبت یا استفاده افراطی از حواس‌پرتی برای اجتناب نیست. هم‌چنین واکنش‌های طبیعی ی را نباید صرفاً به ویژگی‌های فردی تقلیل داد.

بیش‌مصرف و سوءمصرف الکل، آرام‌بخش‌ها و سایر مواد پس از تروماهای جمعی

افزایش مصرف الکل، سیگار، داروها (به‌ویژه بنزودیازپین‌ها) و سایر مواد پس از تروماهای جمعی پدیده‌ای شناخته‌شده است. در جریان رویدادهای تهدیدکننده گسترده مانند جنگ، ناامنی اجتماعی، خشونت جمعی یا بلایای طبیعی، هم افرادی که سابقه مصرف مواد داشته‌اند و هم کسانی که پیش‌تر مصرف نداشته‌اند، در معرض افزایش یا شروع مصرف مواد قرار می‌گیرند.

چرا پس از تروما میل به مصرف افزایش می‌یابد؟

تروما با مجموعه‌ای از تجربه‌های روانی و جسمی همراه است؛ از جمله برانگیختگی مفرط، اضطراب منتشر، گوش‌به‌زنگی دائمی، بی‌خوابی و کابوس، افکار مزاحم و فلش‌بک، احساس ناتوانی و فقدان کنترل، بی‌حسی هیجانی و نوسان شدید خلق.

در چنین شرایطی، مصرف الکل و داروهای آرام‌بخش ـ به‌ویژه بنزودیازپین‌ها ـ اغلب در قالب «خوددرمانی» شکل می‌گیرد. این مواد در کوتاه‌مدت تنش، اضطراب و بی‌خوابی را کاهش می‌دهند. نیکوتین نیز می‌تواند تنش ادراک‌شده را موقتاً کم کند. این تسکین فوری، در بستر استرس حاد و مزمن، رفتار مصرف را تقویت کرده و احتمال تکرار آن را افزایش می‌دهد.

وضعیت در کادر درمان

کادر درمان علاوه بر تجربه تهدید شخصی، در معرض ترومای ثانویه، مواجهه مکرر با رنج انسانی و فشارهای اخلاقی قرار دارند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد بین ۱۵ تا ۲۵ درصد کارکنان حوزه سلامت پس از تروماهای گسترده، افزایش مصرف الکل یا داروهای خواب‌آور و آرام‌بخش را گزارش می‌کنند. این افزایش معمولاً در ماه‌های نخست پس از بحران رخ می‌دهد و در بسیاری از موارد با کاهش فشار فروکش می‌کند؛ با این حال، در حدود ۵ تا ۱۵ درصد موارد، الگوی مصرف پایدار می‌شود.

شدت علامت‌های اختلال استرس پس از سانحه، بی‌خوابی مزمن و فرسودگی شغلی از پیش‌برنده‌های اصلی افزایش مصرف در این گروهند. شیفت‌های طولانی، دسترسی آسان‌تر به دارو، فرهنگ حرفه‌ای مبتنی بر انکار آسیب‌پذیری، نگرانی از انگ و پیامدهای شغلی و «تاب‌آوری اجباری» از عوامل تشدیدکننده این روند محسوب می‌شوند. بر اساس برخی از همین دلایل، نیروهای نظامی و امنیتی هم در خطری مشابه قرار دارند.

رویکرد بالینی یکپارچه: درک کارکرد مصرف، کاهش انگ و مداخله زودهنگام

در مواجهه با افزایش مصرف مواد در بستر تروما، تمرکز صرف بر برچسب «سوءمصرف» کافی نیست. پرسش بالینی محوری این است: فرد با مصرف، در حال تنظیم چه تجربه‌ای است؟ آیا هدف کاهش اضطراب حاد است؟ یا بهبود خواب؟ خاموش‌کردن افکار مزاحم؟ یا مقابله با بی‌حسی هیجانی؟

در عمل مشاهده می‌شود اضطراب حاد اغلب با بنزودیازپین‌ها خوددرمانی می‌شود، بی‌خوابی با الکل یا داروهای خواب‌آور مدیریت می‌شود، بی‌حسی هیجانی با مصرف الکل کاهش می‌یابد و اضطراب مزمن با مصرف مکرر سیگار تسکین داده می‌شود. این نگاه کارکردی، رویکرد درمانی را از قضاوت به فهم بالینی تغییر می‌دهد.

در عین حال، باید به موانع دریافت کمک در میان کادر درمان توجه داشت. انگ اجتماعی، ترس از آسیب به موقعیت شغلی، نگرانی از ثبت رسمی مشکل و محدودیت زمانی از مهم‌ترین مانع‌ها هستند. بنابراین ایجاد فضای امن، تأکید بر محرمانگی و کاهش رویکرد تنبیهی اهمیت اساسی دارد.

از منظر بالینی، مصرف الکل و بنزودیازپین‌ها اگرچه در کوتاه‌مدت علائم را کاهش می‌دهد، اما در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند با تشدید علامت‌های تروما، اختلال خواب پایدار و افزایش خطر وابستگی همراه باشد. به همین دلیل، مداخله باید زودهنگام، حمایتی و ساختاریافته باشد.

مداخلات اولیه شامل آموزش بهداشت خواب و پرهیز از تجویز طولانی‌مدت بنزودیازپین‌هاست؛ در صورت ضرورت، مصرف باید کوتاه‌مدت و همراه با برنامه مشخص قطع باشد. در موارد مناسب، استفاده از داروهایی با خطر وابستگی کمتر می‌تواند مدنظر قرار گیرد. درمان‌های مبتنی بر تروما، آموزش مهارت‌های تنظیم هیجان و تکنیک‌های آرام‌سازی غیردارویی نیز نقش مهمی دارند. علاوه

بر این، مداخله‌های کوتاه مبتنی بر مصاحبه انگیزشی، تعیین حدود مصرف و بازبینی منظم می‌تواند از تثبیت الگوی مصرف جلوگیری کند.

در تروماهای جمعی، افزایش مصرف مواد می‌تواند به موج ثانویه‌ای از آسیب منجر شود. رویکردی که بر درک رنج زیربنایی، کاهش انگ، شناسایی زودهنگام و مداخله پیش‌گیرانه استوار باشد، بخش جدایی‌ناپذیر مراقبت جامع سلامت روان در بحران محسوب می‌شود.

بخش چهارم

سوگ

ازآنجایی‌که این راهنما با هدف حمایت از کارکنان سلامت با تجربه سوگ تهیه شده و متخصصان سلامت روان در برنامه‌های حمایت روان‌شناختی همتایان نقش درمانگر ندارند، در متن از واژه **«تسهیل‌گر»** استفاده می‌شود تا تأکید شود تمرکز این راهنما بر ارائه حمایت روان‌شناختی و تسهیل فرایند سوگ است، نه انجام درمان‌های عمیق و تخصصی روان‌درمانی.

سوگ چیست؟

سوگ واکنشی انسانی، طبیعی و اغلب دردناک به تجربه فقدان است. این واکنش نه نشانه ضعف و نه نشانه بیماری، بلکه بازتابی از دلبستگی‌های عمیقی است که انسان در روابط، معناها و تجربه‌های زندگی خود شکل می‌دهد.

اگرچه سوگ اغلب با از دست دادن یک فرد مهم تداعی می‌شود، اما محدود به فقدان به علت مرگ نیست. افراد ممکن است در مواجهه با انواع مختلف فقدان، تجربه سوگ داشته باشند؛ از جمله از دست دادن یک رابطه مهم، از دست دادن احساس امنیت یا ثبات، از دست دادن موقعیت‌های شغلی یا اجتماعی، از دست دادن آینده‌ای که برای خود تصور کرده‌اند، یا مواجهه با تغییر ناگهانی و ناخواسته در شرایط زندگی.

در این معنا، سوگ می‌تواند پاسخی به «آنچه از دست رفته» یا «آنچه انتظار می‌رفت باشد اما محقق نشده» باشد.

از منظر روان‌شناختی، سوگ صرفاً یک تجربه هیجانی نیست. این تجربه می‌تواند به‌صورت بحرانی در معنا و هویت فرد ظاهر شود. در پی فقدان، جهان فرد ممکن است موقتاً نامفهوم، بی‌معنا یا ناپایدار به نظر برسد و فرد، علاوه بر غم از دست دادن، با پرسش‌هایی اساسی درباره خود، دیگران و معنای زندگی مواجه شود.

در این چارچوب، هدف از مواجهه با سوگ «پشت سر گذاشتن» یا حذف آن نیست، بلکه کمک به فرد برای ادغام تجربه این فقدان در زندگی و بازسازی معناست.
نکته مهم برای تسهیل‌گر این است که بسیاری از واکنش‌های شدید هیجانی، مانند غم عمیق، خشم، اضطراب، احساس پوچی یا حتی بی‌حسی، می‌توانند بخشی از روند طبیعی سازگاری باشند. نقش تسهیل‌گر این نیست که این واکنش‌ها را به‌سرعت برچسب‌گذاری یا اصلاح کند، بلکه لازم است به فرد کمک کند آن‌ها را در فضایی امن تجربه و درک کند.

ویژگی‌های سوگ

سوگ تجربه‌ای یکسان و قابل پیش‌بینی نیست. شناخت ویژگی‌های آن به تسهیل‌گر کمک می‌کند تا واکنش‌های فرد را بهتر درک کند و از قضاوت، برچسب‌گذاری یا مداخله زودهنگام و نامناسب پرهیز کند.

سوگ فرایندی غیرخطی است.

سوگ مسیر مشخص و مرحله‌به‌مرحله‌ای ندارد. افراد ممکن است بین حالت‌های مختلف هیجانی جابه‌جا شوند. برای مثال، فردی که یک روز احساس آرامش نسبی دارد، ممکن است روز بعد دوباره دچار اندوه شدید شود. این نوسان به معنای بازگشت به عقب نیست، بلکه بخشی طبیعی از فرایند سوگ است.

سوگ تجربه‌ای شخصی و منحصربه‌فرد است.

هیچ دو نفری سوگ را دقیقاً به یک شکل تجربه نمی‌کنند. شدت، مدت و نحوه بروز سوگ به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله نوع رابطه با فرد یا موضوع از دست‌رفته، ویژگی‌های شخصیتی، تجربه‌های قبلی فقدان و زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی.
شدت سوگ لزوماً به نزدیکی ظاهری رابطه وابسته نیست. در بسیاری از موارد، فقدان‌هایی که از بیرون کم‌اهمیت‌تر به نظر می‌رسند، می‌توانند سوگ عمیق‌تری ایجاد کنند. کیفیت رابطه، معنای شخصی آن، وابستگی‌های هیجانی، تعارض‌های حل‌نشده و نقشی که آن رابطه در هویت فرد داشته، همگی می‌توانند بر شدت سوگ تأثیر بگذارند.

برای مثال، فردی ممکن است پس از فوت یکی از والدین، سوگی نسبتاً آرام تجربه کند، اما از دست دادن یک دوست نزدیک یا شریک عاطفی برای او بسیار ویرانگر باشد، زیرا آن رابطه نقش مهم‌تری در حمایت هیجانی او داشته است. فرد دیگری ممکن است برای رابطه‌ای که از بیرون کوتاه‌مدت یا کم‌اهمیت به نظر می‌رسد، سوگ شدیدی تجربه کند، زیرا آن رابطه همراه با امید یا معنای خاصی در زندگی او بوده است. هم‌چنین در روابطی که با تعارض یا حرف‌های ناگفته همراه

بوده‌اند، سوگ ممکن است شدیدتر باشد، زیرا علاوه بر فقدان، ممکن است احساس گناه یا ناتمام ماندن ارتباط وجود داشته باشد.
به همین دلیل، قضاوت درباره شدت «مناسب» سوگ یا چگونگی ابراز آن و مقایسه افراد با یکدیگر می‌تواند به درک نادرست و حتی آسیب بیشتر منجر شود.

سوگ نوسان‌دار است.

افراد در سوگ معمولاً بین دو وضعیت در نوسان هستند: از یک سو، مواجهه با فقدان و تجربه هیجان‌های مرتبط، و از سوی دیگر، فاصله گرفتن موقت از آن و درگیر شدن در فعالیت‌های روزمره. این نوسان به فرد کمک می‌کند تا به‌تدریج ظرفیت تحمل هیجانی خود را تنظیم کند. نبود این نوسان، برای مثال غرق‌شدگی کامل در درد یا اجتناب کامل و مداوم، می‌تواند نشانه‌هایی از دشواری در پردازش سوگ باشد.

برای مثال، فرد ممکن است در یک جلسه به‌شدت گریه کند و درباره فقدان صحبت کند، اما در جلسه بعد بیشتر درباره کار یا مسائل روزمره حرف بزند. این تغییر به معنای فرار از سوگ نیست، بلکه بخشی از تنظیم طبیعی هیجان است. هم‌چنین فردی ممکن است در طول روز لحظاتی از غم شدید را تجربه کند، اما در زمان‌هایی دیگر بتواند بخندد یا به فعالیت‌های عادی بپردازد. این تناقض ظاهری، طبیعی است.

مثال:
«فکر می‌کردم بهتر شده‌ام، اما دوباره حالم بسیار بد شده... انگار به نقطه اول برگشتم.»
مداخله نامناسب:
«این یعنی هنوز بهبود پیدا نکرده‌اید.»
مداخله مناسب:
«سوگ معمولاً به‌صورت خطی پیش نمی‌رود و می‌تواند نوسان داشته باشد... این وضعیت به معنای بازگشت به نقطه اول نیست، بلکه بخشی طبیعی از این فرایند است.»

سوگ چندبعدی است.

سوگ فقط به احساس غم محدود نمی‌شود و می‌تواند در ابعاد مختلف بروز پیدا کند:

- هیجانی: غم، خشم، اضطراب، احساس گناه، پوچی.
- شناختی: سردرگمی، نشخوار ذهنی، دشواری در تمرکز.
- جسمانی: خستگی، اختلال خواب، تغییر اشتها.
- رفتاری: کناره‌گیری یا برعکس، بی‌قراری
- اجتماعی: تغییر در روابط بین فردی.

شناخت این ابعاد به تسهیل‌گر کمک می‌کند تا تجربه فرد را به‌صورت جامع‌تر ببیند و آن را صرفاً به یک نشانه خاص تقلیل ندهد.

سوگ با دلبستگی پیوند دارد.

شدت و کیفیت سوگ تا حد زیادی با میزان و نوع دلبستگی فرد به آنچه از دست رفته مرتبط است. با این حال، این دلبستگی صرفاً به نزدیکی ظاهری رابطه محدود نمی‌شود، بلکه به معنای شخصی، نقش آن رابطه در زندگی فرد و تجربه‌های هیجانی مرتبط با آن وابسته است.

دلبستگی می‌تواند شامل احساس امنیت، هویت، معنا، امید یا حتی بخشی از تصویر فرد از خود باشد. از دست دادن چنین پیوندی می‌تواند باعث شود فرد نه‌تنها دیگری، بلکه بخشی از خود یا جهان معنایی‌اش را نیز از دست داده است.

برای مثال، فردی که بخش مهمی از هویت خود را در نقش «فرزند مراقب» تعریف کرده، ممکن است پس از فوت والد، علاوه بر سوگ، احساس سردرگمی هویتی را تجربه کند. یا فردی که یک رابطه عاطفی را از دست داده، ممکن است احساس کند آینده‌ای که برای خود تصور کرده بود نیز از بین رفته است. در اینجا سوگ فقط برای یک فرد نیست، بلکه برای «آینده‌ای‌ست که قرار بود باشد».

برای درک بهتر تجربه سوگ، این پرسش می‌تواند راهگشا باشد:
این فقدان چه معنایی برای این فرد داشته است و چه چیزی را در زندگی او نمایندگی می‌کرده است؟

پذیرش واقعیت فقدان معمولاً یک فرایند تدریجی است و ممکن است زمان ببرد.

فرد ممکن است میان دانستن و باور کردن در نوسان باشد. ممکن است بارها با خود تکرار کند که این اتفاق افتاده، اما همچنان در سطحی عمیق انتظار داشته باشد که وضعیت به حالت قبل بازگردد. این تجربه به‌ویژه در فقدان‌های ناگهانی، تکان‌دهنده یا در شرایطی که فرصت خداحافظی وجود نداشته، بیشتر دیده می‌شود. نقش تسهیل‌گر کمک به نام‌گذاری و واقعی‌تر شدن تدریجی فقدان است. این کار از طریق استفاده از زبان روشن و غیرمبهم، فراهم کردن فضای امن برای بیان، دعوت تدریجی به روایت واقعه از طریق سازمان دادن به آنچه در ذهن فرد پراکنده و غیر واقعی است و توجه به ظرفیت هیجانی فرد انجام می‌شود.

مثال:

فرد: «احساس می‌کنم انگار رفته سفر.»

تسهیل‌گر: «به نظر می‌رسد پذیرفتن اینکه او فوت کرده برای شما بسیار دشوار است. اگر بخواهید می‌توانید درباره‌ش حرف بزنید.»

مداخلات نامناسب:

- فشار برای پذیرش سریع
- وادار کردن به بازگویی جزییات
- استفاده از جمله‌های کلیشه‌ای
- عجله برای ورود به معنا دادن
- تفسیر زودهنگام

سوگ جمعی و شرایط بحران

سوگ همیشه تجربه‌ای صرفاً فردی نیست. در برخی شرایط، گروه‌های بزرگی از افراد به‌طور هم‌زمان در معرض رویدادهایی قرار می‌گیرند که می‌تواند منجر به تجربه سوگ جمعی شود. سوگ جمعی به مجموعه‌ای از واکنش‌های هیجانی، روانی و اجتماعی گفته می‌شود که در پی یک فقدان گسترده یا یک رویداد آسیب‌زا، بخش وسیعی از یک جامعه یا گروه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این شرایط، افراد ممکن است حتی بدون تجربه فقدان مستقیم، دچار احساساتی مانند غم، خشم، اضطراب، بی‌حسی هیجانی یا سردرگمی شوند. این واکنش‌ها اغلب ناشی از عواملی مانند هم‌ذات‌پنداری با افرادی که آسیب دیده‌اند، احساس تهدید یا ناامنی مشترک و معنای نمادین رویداد برای جامعه هستند.

در سوگ جمعی، علاوه بر تجربه فردی، احساس امنیت روانی و ثبات در سطح جمعی نیز ممکن است دچار اختلال شود. افراد ممکن است جهان را کمتر قابل پیش‌بینی، کمتر امن یا کمتر معنادار تجربه کنند. در چنین شرایطی، پرسش‌هایی درباره آینده، اعتماد و امکان کنترل بر زندگی نیز پررنگ‌تر می‌شود. یکی از ویژگی‌های مهم این وضعیت آن است که تسهیل‌گر نیز ممکن است هم‌زمان تحت تأثیر همان رویداد قرار داشته باشد. این وضعیت که به آن آسیب مشترک یا درگیری هیجانی مشترک گفته می‌شود، می‌تواند مرزهای حرفه‌ای و شخصی را تحت فشار قرار دهد و بر کیفیت مداخله اثر بگذارد.

برای مثال، فردی ممکن است فقدان مستقیمی را تجربه نکرده باشد، اما به دلیل قرار گرفتن مداوم در معرض اخبار یا روایت‌های آسیب‌زا، دچار غم، اضطراب یا بی‌حسی شود. یا فردی ممکن است درباره آینده احساس ناامنی یا ابهام داشته باشند و این تجربه برای او به اندازه یک فقدان واقعی دردناک باشد. در چنین شرایطی، تسهیل‌گر نیز ممکن است متوجه شود که خود با احساساتی مانند خستگی هیجانی، اندوه یا کاهش تمرکز مواجه شده است.

در مواجهه با سوگ جمعی، توجه به چند نکته اهمیت دارد. نخست آن‌که واکنش‌های شدید هیجانی باید به‌عنوان پاسخ‌هایی قابل فهم به شرایط دشوار در نظر گرفته شوند، نه نشانه‌هایی از اختلال. دوم آن‌که تلاش برای اصلاح سریع حال فرد یا آرام‌سازی فوری، معمولاً مؤثر نیست و حتی ممکن است فاصله ایجاد کند؛ در این شرایط، درک و همدلی در اولویت قرار دارد.

هم‌چنین باید توجه داشت که برخی افراد ممکن است فقدان مشخصی نداشته باشند، اما هم‌چنان نیازمند حمایت باشند. در مراحل اولیه چنین شرایطی، تمرکز اصلی بر ایجاد احساس امنیت، کاهش پریشانی حاد و حمایت عملی است. در این مرحله، استفاده از رویکردهایی مانند کمک‌های اولیه روان‌شناختی می‌تواند مفید باشد و در عین حال باید از وادار کردن افراد به بازگویی زودهنگام تجربه‌های دردناک پرهیز شود، زیرا این کار می‌تواند پریشانی را افزایش دهد.

با عبور از مرحله حاد، می‌توان از مداخلات ساختارمندتر مانند آموزش روان‌شناختی، گروه‌های حمایتی و فعالیت‌های جمعی استفاده کرد که به پردازش تجربه و کاهش احساس تنهایی کمک می‌کنند.

مثال:

«افراد زیادی شرایط سخت‌تری دارند، بنابراین شاید حق نداشته باشم این‌قدر ناراحت باشم.»

مداخله نامناسب:

«درست است، شرایط دیگران واقعاً سخت‌تر است و شما خوش‌شانس بودید.»

مداخله مناسب:

«اینکه دیگران نیز آسیب دیده‌اند، از اهمیت تجربه شما کم نمی‌کند و به این معنی نیست که ما حق ندارید ناراحت باشید.»

اصول پایه کار با سوگ برای تسهیل‌گر

در مواجهه با سوگ، به‌ویژه در شرایطی که افراد با فقدان‌های فردی یا فشارهای گسترده زندگی روبه‌رو هستند، نگرش تسهیل‌گر به سوگ و چگونگی حضور او بسیار تاثیرگذار است. اصول زیر چارچوبی عملی فراهم می‌کنند تا تسهیل‌گر بدون عجله برای بهبودی، بتواند فضایی امن، قابل اعتماد و حمایتی ایجاد کند.

عادی‌سازی واکنش‌ها در تجربه سوگ

افرادی که در سوگ هستند، اغلب نگران این هستند که آیا واکنش‌هایشان طبیعی است یا نه. یکی از مهم‌ترین نقش‌های تسهیل‌گر این است که به آن‌ها کمک کند بدانند بسیاری از تجربه‌هایشان قابل انتظار و طبیعی است.
واکنش‌هایی مانند گریه‌های مکرر، خشم یا تحریک‌پذیری، اضطراب یا بی‌قراری، احساس پوچی یا بی‌معنایی، بی‌حسی هیجانی و نوسان بین حال خوب و بد، بخشی از روند طبیعی سوگ هستند.
عادی‌سازی به معنای کوچک کردن رنج نیست، بلکه به معنای قابل فهم کردن تجربه است.

مثال:
فرد می‌گوید «یک لحظه حال بسیار بدی دارم و لحظه‌ای بعد انگار هیچ اتفاقی نیفتاده... نگرانم این وضعیت طبیعی نباشد.»
مداخله نامناسب:
«این نوسان طبیعی نیست، باید خودتان را کنترل کنید.»
مداخله مناسب:
«بسیاری از افراد در سوگ همین نوسان را تجربه می‌کنند. این به این معنا نیست که مشکلی پیش آمده است.»

پرهیز از برچسب‌زنی زودهنگام

در مواجهه با سوگ، ممکن است وسوسه شویم که واکنش‌های فرد را به‌سرعت در قالب یک اختلال ببینیم. این کار می‌تواند باعث شود فرد احساس کند مشکلی در او وجود دارد یا تجربه‌اش غیرطبیعی است. نقش تسهیل‌گر در این سطح تشخیص‌گذاری نیست، بلکه کمک به این است که مشخص شود آیا واکنش‌ها در چارچوب سوگ طبیعی قرار دارند یا نیاز به بررسی تخصصی‌تر وجود دارد.

مثال:

فرد: «هر روز گریه می‌کنم، یعنی افسرده شده‌ام؟»

پاسخ مناسب:

«گریه کردن در چنین شرایطی بسیار شایع است. شاید بهتر باشد ببینیم این حالت چقدر روی زندگی روزمره شما تأثیر گذاشته است.»

ایجاد و حفظ احساس امنیت روانی

بسیاری از افراد در سوگ احساس می‌کنند که جهان دیگر قابل پیش‌بینی نیست، کسی آن‌ها را درک نمی‌کند، یا باید سریع‌تر حالشان بهتر شود. در این شرایط، ایجاد احساس امنیت روانی اهمیت اساسی دارد. امنیت روانی به این معناست که فرد احساس کند می‌تواند بدون ترس صحبت کند، قضاوت نمی‌شود و برای بهبودی تحت فشار نیست.

این احساس بیش از آن‌که از طریق تکنیک‌های پیچیده ایجاد شود، از طریق حضور تسهیل‌گر شکل می‌گیرد: گوش دادن بدون قطع کردن، تحمل سکوت و استفاده از جمله‌های ساده و همدلانه.

برای مثال، جملاتی مانند «باید خیلی سخت باشد» یا «اگر بخواهید، می‌توانید بیشتر برای من بگویید» می‌توانند به ایجاد این فضا کمک کنند. در مقابل، جملاتی مانند «باید قوی باشید» یا «زمان همه‌چیز را حل می‌کند» معمولاً احساس فشار یا نادیده گرفته شدن ایجاد می‌کنند.

توجه به زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی

نحوه تجربه و ابراز سوگ در افراد متفاوت است و به زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و فردی آن‌ها بستگی دارد. برای مثال، در برخی فرهنگ‌ها ابراز آشکار هیجان در جمع پذیرفته شده و حتی تشویق می‌شود، در حالی که در برخی دیگر، کنترل هیجان یا ابراز آن در فضای خصوصی ترجیح داده می‌شود. تسهیل‌گر لازم است این تفاوت‌ها را بشناسد و به شیوه تجربه و ابراز سوگ در فرد احترام بگذارد، بدون آن‌که آن را با معیارهای شخصی خود بسنجد.

کمک به معناسازی

در سوگ، تنها یک فرد یا یک وضعیت از دست نمی‌رود؛ در بسیاری از موارد، معناها، نقش‌ها و تصویر فرد از آینده نیز تغییر می‌کنند. در پایان فرایند سوگ، هدف قطع رابطه با فرد از دست‌رفته یا فراموش کردن او نیست، بلکه تغییر شکل این رابطه است. در این مرحله، فرد به‌تدریج یاد می‌گیرد که پیوند خود را حفظ کند، در حالی که زندگی را ادامه می‌دهد. این تغییر از حضور بیرونی به حضور درونی اتفاق می‌افتد.

سوگ به معنای فراموش کردن یا پایان دادن به رابطه نیست.

بلکه فرایندی است که در آن فرد:

- با واقعیت فقدان روبه‌رو می‌شود.
- احساسات خود را تجربه می‌کند.
- با زندگی جدید سازگار می‌شود.
- و رابطه‌ای تازه و درونی با فرد یا آنچه از دست‌رفته می‌سازد.

این فرایند خطی نیست، اما شناخت آن می‌تواند به تسهیل‌گر کمک کند حضور دقیق‌تر و مؤثرتری داشته باشد. تسهیل‌گر می‌تواند به فرد کمک کند تا به‌تدریج بفهمد این فقدان چه تغییری در زندگی او ایجاد کرده است و چه معنایی برای او داشته است.

مثال:

فرد: «احساس می‌کنم همه برنامه‌هایی که داشتم از بین رفته»

تسهیل‌گر می‌تواند پاسخ دهد: «به نظر می‌رسد علاوه بر خود این رابطه، آینده‌ای که تصور کرده بودید هم از دست رفته است.»

این نوع بازتاب به فرد کمک می‌کند تجربه خود را عمیق‌تر درک کند.

توجه: شتاب در معناسازی و یا تلاش برای القای معنا در فقدان می‌تواند آسیب‌رسان باشد. نقش تسهیل‌گر کمک به فرد برای یافتن معناست و نه تلقین آنچه خود فکر می‌کند.

مثال:

فرد: «هیچ‌چیز برایم معنا ندارد.»

مداخله نامناسب:

«حتماً حکمتی داشته است، بعداً متوجه می‌شوید.»

مداخله مناسب:

«به نظر می‌رسد این اتفاق تأثیر عمیقی بر معنای زندگی شما گذاشته است... می‌توانیم بیشتر درباره این تجربه صحبت کنیم.»

تقویت احساس کنترل و توانمندی

پس از دوره حاد سوگ، فرد وارد مرحله‌ای می‌شود که باید با یک واقعیت اساسی روبه‌رو شود: زندگی ادامه دارد، اما در شرایطی متفاوت از گذشته. فقدان دیگر فقط به‌صورت یک تجربه هیجانی نیست، بلکه به‌صورت تغییر در ساختار زندگی فرد خود را نشان می‌دهد. بسیاری از افراد در این نقطه متوجه می‌شوند که فقدان بخش‌هایی از نقش‌ها، مسوولیت‌ها، برنامه‌ها و حتی هویت آن‌ها را نیز تغییر داده است.

هدف کمک به فرد برای این است که بتواند:

- زندگی روزمره را به‌تدریج از سر بگیرد.
- با تغییر در نقش‌ها و مسوولیت‌ها سازگار شود.
- تصویر جدیدی از خود و زندگی‌اش شکل دهد.
- و با تغییر در معنا و نگاه خود به جهان کنار بیاید.

در سوگ، افراد ممکن است احساس کنند کنترل خود را بر زندگی از دست داده‌اند. حتی اقدامات کوچک می‌توانند به بازگشت تدریجی احساس تسلط و کنترل کمک کنند. تسهیل‌گر می‌تواند با تمرکز بر کارهای ساده و قابل انجام، به فرد کمک کند دوباره احساس توانمندی را تجربه کند.
برای مثال، می‌توان پرسید: «در شرایط فعلی، چه کاری ـ حتی کوچک ـ وجود دارد که از عهده آن برمی‌آیید؟» یا «چه چیزی در این لحظه می‌تواند کمی به شما کمک کند؟»

مثال:
فرد: «هیچ کاری از دستم برنمی‌آید... هر اقدامی بی‌فایده به نظر می‌رسد.»
مداخله نامناسب:
«نباید اینطور فکر کنید، باید سعی کنید.»
مداخله مناسب:
«درست است که بسیاری از عوامل خارج از کنترل شما بوده‌اند... اما شاید بتوانیم با هم بررسی کنیم چه کارهای کوچکی الان برای شما قابل انجام هستند.»

فعال‌سازی حمایت‌های اجتماعی

تنهایی می‌تواند تجربه سوگ را سنگین‌تر کند. تسهیل‌گر می‌تواند به فرد کمک کند تا منابع حمایتی خود را شناسایی و در صورت تمایل از آن‌ها استفاده کند.

برای مثال، می‌توان پرسید: «آیا کسی هست که بتوانید با او صحبت کنید؟» یا «در این شرایط، ترجیح می‌دهید تنها باشید یا حضور فردی دیگر می‌تواند کمک‌کننده باشد؟»

در اینجا مهم است که حمایت پیشنهاد شود، نه تحمیل.

مثال:

فرد: *«با کسی صحبت نمی‌کنم... کسی درکم نمی‌کند.»*

مداخله نامناسب:

«باید حتماً با دیگران صحبت کنید.»

مداخله مناسب:

«به نظر می‌رسد برقراری ارتباط در حال حاضر دشوار شده است... اگر بخواهید، می‌توانیم بررسی کنیم ببینیم کسی هست که حرف زدن با او برای شما آسان‌تر باشد.»

راهنمای گام‌به‌گام مواجهه با فرد سوگوار

در مواجهه اولیه با فردی که در سوگ است، تسهیل‌گر ممکن است با سکوت، گریه، خشم یا حتی بی‌حسی کامل مواجه شود. در این موقعیت، مهم‌ترین نکته این است که هدف درمان یا تغییر حال نیست، بلکه کاهش فشار اولیه، ایجاد احساس امنیت و فراهم کردن یک حضور قابل اتکا است.

گام اول: حضور مؤثر و آغاز ارتباط

در بسیاری از موارد، فرد در سوگ پیش از هر چیز نیاز دارد احساس کند که کسی کنار او هست.
در این مرحله:

- با لحن آرام و محترمانه صحبت کنید.
- از جملات ساده و روشن استفاده کنید.
- فاصله فیزیکی، تماس چشمی و نحوه حضور خود را متناسب با موقعیت تنظیم کنید.

مثال:

- «اگر بخواهید، می‌توانیم با هم صحبت کنیم»
- «می‌توانید کمی از حال خود بگویید؟»

اگر فرد واکنش نشان نداد:

- عجله نکنید.
- سکوت را تحمل کنید.
- حضور خود را حفظ کنید.
- در برخی موارد، صرف نشستن در کنار فرد، بدون فشار برای صحبت، خود یک مداخله مؤثر است.

گام دوم: گوش دادن فعال

گوش دادن در اینجا به معنای شنیدن واقعی است، نه صرفاً منتظر ماندن برای پاسخ دادن.

در این مرحله:

- صحبت فرد را قطع نکنید.
- برای اصلاح یا تفسیر عجله نکنید.
- از جملات کوتاه و بازتابی استفاده کنید.

نمونه:

فرد: «اصلاً باورم نمی‌شود... انگار خواب هستم.»

تسهیل‌گر: «به نظر می‌رسد هنوز برای شما غیرقابل‌باور است...»

فرد: «مدام فکر می‌کنم شاید اشتباهی شده»

تسهیل‌گر: «بله پذیرش این اتفاق خیلی سخت است...»

فرد: «از همه چیز عصبانی هستم.»

تسهیل‌گر: «به نظر می‌رسد خشم زیادی را تجربه می‌کنید...»

هدف، پاسخ دادن نیست؛ هدف، ماندن و شنیدن است.

گام سوم: تحمل هیجان

در مواجهه با هیجان‌های شدید، به‌ویژه گریه، آشفتگی یا خشم، ممکن است تسهیل‌گر تمایل داشته باشد سریع فرد را آرام کند. اما در سوگ، تجربه هیجان بخشی از روند طبیعی است.

در این مرحله:

- از آرام‌سازی فوری پرهیز کنید.
- اجازه دهید هیجان در حد قابل تحمل تجربه شود.

- حضور خود را حفظ کنید.

اگر فرد گریه می‌کند، می‌توان:

- در سکوت کنار او ماند.
- دستمال در اختیار او قرار داد.
- با جمله‌هایی کوتاه همراهی کرد، مانند: «باید خیلی سخت باشد»
- هدف این مرحله حذف هیجان نیست، بلکه کمک به تحمل آن است.

مثال: (فرد در حال گریه سکوت می‌کند)
مداخله نامناسب:
«آرام باشید، نفس عمیق بکشید، خودتان را کنترل کنید.»
مداخله مناسب:
(سکوت، حضور)
«معلوم است خیلی دلتنگید...»

گام چهارم: بررسی نیازهای فوری

در مواجهه اولیه، تمرکز اصلی باید بر نیازهای پایه و فوری باشد، نه تحلیل روان‌شناختی.
سؤال‌های راه‌گشا:

- *«در حال حاضر کسی در خانه پیش شما هست؟»*
- *«آخرین بار کی غذا خورده‌اید؟»*
- *«امشب کجا می‌مانید؟»*

مثال:

فرد: «از صبح چیزی نخورده‌ام، اصلا اشتها ندارم»

تسهیل‌گر: «شاید بهتر باشد الان یک چیزی بخورید. آبمیوه یا چای میل دارید بیاورم؟»

در این مرحله، کمک‌های ساده و عملی می‌توانند تأثیر قابل توجهی داشته باشند.

گام پنجم: عادی‌سازی

بسیاری از افراد نگران این هستند که واکنش‌هایشان غیرطبیعی است. عادی‌سازی می‌تواند به کاهش این نگرانی کمک کند.

نمونه:

فرد: «یک لحظه حالم خیلی بد است، یک لحظه انگار هیچ اتفاقی نیفتاده.»

تسهیل‌گر: «خیلی‌ها در سوگ این تجربه را دارند.»

فرد: «احساس می‌کنم بی‌حس شده‌ام.»

تسهیل‌گر: «بی‌حسی نیز می‌تواند یکی از واکنش‌های سوگ باشد، به‌ویژه در مواجهه با فشار زیاد.»

گام ششم: پرهیز از فشار برای صحبت

همه افراد در مواجهه اولیه تمایل یا آمادگی برای صحبت ندارند.

اگر فرد تمایلی به صحبت نشان نداد:

- به این انتخاب احترام بگذارید.
- مسیر را برای صحبت در آینده باز نگه دارید.

مثال:
«کاملاً قابل درک است. هر زمان که آمادگی داشتید، می‌توانیم درباره آن صحبت کنیم.»

گام هفتم: ارایه حمایت ساده و قابل انجام

در این مرحله:
از ارایه تکنیک‌های پیچیده پرهیز کنید و تمرکز بر اقدامات ساده و عملی باشد.

مثال:
«اگر امشب تنها نمانید، شاید کمک‌کننده باشد.»
«استراحت کوتاه می‌تواند به تنظیم وضعیت جسمی شما تو این شرایط سخت کمک کند.»

گام هشتم: تشخیص نیاز به ارجاع

در حین مواجهه، تسهیل‌گر باید به نشانه‌هایی توجه کند که نشان‌دهنده نیاز به مداخله تخصصی‌تر هستند. برای مطالعه بیشتر به بخش «ارجاع به مراقبت‌های تخصصی» در این راهنما مراجعه کنید. به طور خاص در مورد سوگ، توجه به سوگ پیچیده یا افسردگی اهمیت دارد.

تمایز سوگ طبیعی از سوگ پیچیده

سوگ در اغلب موارد فرایندی طبیعی و قابل انتظار است که به‌تدریج، هرچند با نوسان، به سمت سازگاری پیش می‌رود. با این حال، در برخی موارد ممکن است این فرایند به شکلی پیش برود که نیاز به توجه تخصصی‌تری داشته باشد.

در سوگ پیچیده یا طولانی‌شده، شدت علائم کاهش پیدا نمی‌کند یا حتی با گذشت زمان پایدار می‌ماند و می‌تواند به‌طور جدی بر عملکرد روزمره فرد تأثیر بگذارد. فرد ممکن است همچنان درگیر دلتنگی شدید، اشتغال ذهنی مداوم با فقدان، یا ناتوانی در بازگشت به فعالیت‌های معمول باشد. تشخیص این وضعیت بر عهده متخصص است، اما برای تسهیل‌گر مهم است که در صورت مشاهده اختلال پایدار در عملکرد، شدت بالای رنج یا عدم تغییر در وضعیت فرد، موضوع ارجاع را در نظر داشته باشد.

تمایز سوگ طبیعی از افسردگی

یکی از پرسش‌های رایج در مواجهه با سوگ این است که آیا تجربه فرد بخشی از سوگ طبیعی است یا نشان‌های از افسردگی.در سوگ، احساس معمولاً با فقدان مرتبط است و ممکن است به‌صورت نوسانی تجربه شوند. فرد می‌تواند در کنار غم، لحظه‌هایی از آرامش یا حتی تجربه‌های مثبت را نیز داشته باشد.

در مقابل، در افسردگی، احساس غم یا بی‌لذتی معمولاً پایدارتر، فراگیرتر و کمتر وابسته به موقعیت خاص است. در این حالت، کاهش انگیزه، افت انرژی، و دیدگاه منفی نسبت به خود، جهان و آینده به‌صورت گسترده‌تری دیده می‌شود. وجود افکار آسیب به خود یکی از نشانه‌های هشدار جدی برای ارجاع تخصصی است.

با این‌حال، تمایز دقیق این دو نیازمند ارزیابی تخصصی‌ست و در صورت وجود تردید، ارجاع به متخصص توصیه می‌شود.

گام نهم: خودمراقبتی در تسهیل‌گر

تسهیل‌گر ممکن است در مواجهه با سوگ و تجربه‌های هیجانی افراد خود تحت تأثیر قرار بگیرد. برای مطالعه بیشتر به بخش «خودمراقبتی» در این راهنما مراجعه کنید.

احساس گناه بازمانده

احساس گناه بازمانده یکی از تجربه‌های مهم، پیچیده و گاه بسیار فرساینده در سوگ است. این احساس معمولاً زمانی شکل می‌گیرد که فرد زنده مانده، اما دیگری نه؛ یا زمانی که فرد خود را در موقعیتی می‌بیند که شاهد رنج، آسیب یا فقدان بوده و ذهن او به‌طور مکرر این پرسش‌ها را تکرار می‌کند:

- «چرا من ماندم و او نه؟»
- «آیا می‌توانستم کاری انجام دهم؟»
- «آیا کوتاهی کردم؟»

در این وضعیت، ذهن تلاش می‌کند برای یک تجربه دردناک و گاه غیرقابل‌فهم، توضیحی پیدا کند. یکی از رایج‌ترین این توضیح‌ها، نسبت دادن مسوولیت به خود است. به همین دلیل، احساس گناه بازمانده لزوماً به معنای وجود مسوولیت واقعی نیست، بلکه اغلب نشان‌دهنده تلاش ذهن برای معنا دادن به یک رویداد دشوار است.

احساس گناه بازمانده صرفاً یک فکر گذرا یا یک پشیمانی ساده نیست، بلکه می‌تواند شامل لایه‌های متعددی باشد:

- احساس مسوولیت، واقعی یا خیالی، نسبت به آنچه رخ داده
- احساس ناعادلانه بودن بقا
- خودسرزنشی مداوم
- احساس بدهکاری به فرد از دست‌رفته
- احساس گناه از خوشی یا ادامه زندگی

در بسیاری از موارد، فرد نه فقط برای یک اتفاق، بلکه برای زنده ماندن یا ادامه دادن زندگی خود احساس گناه می‌کند.

در کارکنان سلامت و امدادگران، این احساس می‌تواند شیوع یا شدت بیشتری داشته باشد، زیرا هویت حرفه‌ای آن‌ها با کمک کردن و کاهش رنج دیگران پیوند خورده است.

پذیرفتن این‌که یک رویداد خارج از کنترل بوده، برای برخی از افراد دشوار است. در برخی موارد، این فکر که «من مقصر بودم» قابل‌تحمل‌تر از این است که «هیچ کاری از دستم برنمی‌آمد». گاهی ذهن در مواجهه با رویدادهای شدید، به‌دنبال توضیح می‌گردد و توضیحی که شامل خودسرزنشی است، می‌تواند نسبت به بی‌معنایی مطلق قابل‌تحمل‌تر باشد. در برخی موارد نیز احساس گناه به‌نوعی به رابطه گره می‌خورد: «اگر کمتر رنج بکشم، یعنی او را فراموش کرده‌ام» یا «اگر خودم را ببخشم، یعنی اهمیت او را کم کرده‌ام». در افرادی که در نقش‌های حرفه‌ای یا مراقبتی هستند، احساس گناه می‌تواند از شکاف بین آنچه انتظار داشته‌اند انجام دهند و آنچه واقعاً انجام شده ناشی شود.

تفاوت احساس گناه با مسوولیت واقعی

این تمایز برای تسهیل‌گر بسیار مهم است. احساس گناه به معنای وجود مسوولیت واقعی نیست. در بسیاری از موارد فرد کنترل محدودی بر شرایط داشته است یا اساساً هیچ کنترلی نداشته است، اما از نظر هیجانی خود را کاملاً مسوول می‌داند. بنابراین، کار تسهیل‌گر این نیست که فوراً بگوید «تو مقصر نیستی»، بلکه کمک به فرد برای ایجاد فاصله تدریجی بین احساس و واقعیت است.

نقش تسهیل‌گر می‌تواند دیدن و نام‌گذاری تجربه، عادی‌سازی بدون تأیید خودسرزنشی، جدا کردن احساس از واقعیت، بررسی واقع‌بینانه موقعیت، توجه به نیت فرد، و بازسازی پیوند بدون خودتنبیهی باشد.

مثال:

فرد: «اگر بیشتر پیگیری می‌کردم، شاید این اتفاق نمی‌افتاد.»

تسهیل‌گر: «به نظر می‌رسد ذهنتان مدام به این برمی‌گردد که آیا می‌توانستید کاری انجام دهید یا نه. می‌توانیم با هم بررسی کنیم در آن زمان چه چیزهایی در اختیار شما بوده و چه چیزهایی خارج از کنترل شما بوده است.»

چه زمانی ارجاع لازم است؟

در صورت وجود موارد زیر، ارجاع به خدمات تخصصی ضروری است:

- شدت زیاد احساس گناه و پایداری آن
- اختلال در عملکرد روزمره
- همراهی با افکار آسیب به خود
- انزوای شدید یا ناتوانی در ادامه زندگی

بخش پنجم

خودمراقبتی متخصصان سلامت روان

حمایت از کارکنان نظام سلامت در شرایط جنگ و بی‌ثباتی اجتماعی، نیازمند حضوری حرفه‌ای و مبتنی بر ظرفیت هیجانی پایدار است. متخصصان سلامت روان که در چنین بستری فعالیت می‌کنند، خود نیز در معرض ترومای مشترک قرار دارند. این نوع بحران‌ها می‌توانند حس درماندگی، احساس از دست دادن کنترل، و حتی فرسودگی شغلی را در متخصصان ایجاد کنند. این فشارها باعث می‌شود که توانایی آنها برای ارایه خدمات به مراجعان تحت تاثیر قرار گیرد و در نتیجه، خودمراقبتی بیش از پیش به امری ضروری تبدیل می‌شود.

منبع استرس‌های اصلی در این شرایط عبارتند از:

- ترس از آسیب دیدن یا مرگ خود یا عزیزان
- فشارهای ناشی از دوری از خانواده و عزیزان
- در معرض اخبار نگران‌کننده و متناقض بودن
- مواجهه با فقدان همکاران و نزدیکان
- مسوولیت‌های شغلی سنگین و فشارهای کاری مداوم
- عدم امنیت و بی‌اعتمادی به آینده

استرس مزمن یا مواجهه طولانی‌مدت با بحران می‌تواند اثر منفی قابل توجهی بر سلامت روان متخصصان داشته باشد. این اثرات می‌توانند به کاهش کیفیت کار، اختلال عاطفی و روانی، و در نهایت فرسودگی منجر شوند. از این رو، خودمراقبتی نه امری شخصی و تجملی، بلکه بخشی از مسوولیت حرفه‌ای و پیش‌شرط حفظ کیفیت مداخله است.

خودمراقبتی در این چارچوب به معنای کناره‌گیری نیست، بلکه به معنای حفظ ظرفیت برای ادامه کار حرفه‌ای در شرایط دشوار است و زمانی اثربخش است که به بخشی پایدار از سبک کار حرفه‌ای تبدیل شود، نه تنها زمانی که نشانه‌های فرسودگی ظاهر شده‌اند. در ادامه مروری بر روش‌های موثر در این روند شده است:

۱. مشارکت در سوپرویژن[۱۱] حرفه‌ای

حضور منظم در سوپرویژن فردی یا گروهی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای مراقبت حرفه‌ای است. سوپرویژن به متخصص امکان می‌دهد:

- تجربه‌های دشوار و برانگیزاننده را پردازش کند؛
- مرزهای حرفه‌ای خود را بازبینی و تقویت کند؛
- واکنش‌های هیجانی شخصی را شناسایی و تنظیم کند؛
- فضایی امن برای بازاندیشی حرفه‌ای فراهم کند.
- فضایی برای بازاندیشی درباره موقعیت‌های پیچیده اخلاقی فراهم می‌کند.

در این برنامه سوپرویژن علمی و اجرایی به مدت یک سال تا پایان سال ۱۴۰۵ برای مراکزی پیاده‌سازی این برنامه را انجام می‌دهند در دسترس است. برای هماهنگی سوپرویژن می‌توانید با یکی از روش‌های ذکر شده در قسمت مقدمه با ما تماس بگیرید.

۲. مشارکت در گروه‌های مشورتی همکاران[۱۲]

گروه‌های گفت‌وگوی حرفه‌ای با همکاران هم‌سطح، امکان تبادل تجربه و کاهش احساس انزوا را فراهم می‌کنند. این فضاها فرصتی هستند برای:

- دریافت بازخورد غیرقضاوتی؛
- همفکری درباره چالش‌های بالینی؛
- بازسازی حس همبستگی حرفه‌ای

۳. پایش مستمر وضعیت شخصی

[۱۱] Supervision
[۱۲] Peer Consultation

خودآگاهی نسبت به نشانه‌های فشار مزمن یا فرسودگی مانند خستگی مفرط، تحریک‌پذیری، کاهش تمرکز، بی‌حسی هیجانی، اختلال خواب، یا احساس درماندگی گامی اساسی در پیش‌گیری از آسیب حرفه‌ای است.
در شرایط بحران‌های طولانی‌مدت، لازم است متخصصان به اثر آماده‌باش مداوم، مواجهه بیش از حد با اخبار و انباشت فشار روانی بر خود توجه داشته باشند.

مثال: درمان‌گری متوجه می‌شود در هفته‌های اخیر پس از دیدن اخبار حمله‌ها، تمرکز او در جلسه‌ها پایین آمده یا زودتر از قبل برانگیخته می‌شود. همین آگاهی می‌تواند نشانه‌ای برای کاهش بار کاری یا جست‌وجوی حمایت باشد.

توجه به نیازهای پایه مانند خواب، تغذیه، استراحت، و وقفه‌های کوتاه در کار نیز بخشی از خودمراقبتی حرفه‌ای است.

مثال: بین دو جلسه سنگین، پنج دقیقه راه رفتن، آب خوردن، یا چند تنفس عمیق، مداخله‌ای کوچک اما مؤثر برای تنظیم سیستم عصبی است.

۴. تنظیم مرزهای حرفه‌ای

در شرایط ترومای مشترک، احتمال گسترش بیش از حد نقش حرفه‌ای افزایش می‌یابد. ضروری است که متخصص:

- حدود زمانی و هیجانی خود را به‌روشنی مشخص کند؛
- از در دسترس بودن مداوم و پاسخ‌گویی بی‌وقفه پرهیز کند؛
- مسوولیت بحران‌های ساختاری یا تصمیم‌های کلان را بر عهده نگیرد.

حفظ مرزها نشانه بی‌تفاوتی نیست، بلکه شرط تداوم حضور حرفه‌ای و پایدار است.

مثال: پاسخ ندادن به پیام‌های غیرفوری مراجعان در نیمه‌شب، یا تعیین زمان‌های مشخص برای پاسخ‌گویی، می‌تواند بخشی از مرزبندی سالم باشد.

۵. شناخت محدودیت‌ها و پذیرش حدود اثرگذاری

در بحران‌های گسترده، متخصصان سلامت روان ممکن است با احساس ناتوانی در کاهش همه رنج‌ها یا نجات همه افراد مواجه شوند. تفکیک میان آنچه در حوزه اثرگذاری درمان‌گر قرار دارد و آنچه خارج از کنترل اوست، بخشی از خودمراقبتی حرفه‌ای است.

مثال: درمانگری که خود را مسوول رفع ناامنی، فقدان یا خشونت ساختاری احساس می‌کند، ممکن است دچار احساس شکست اخلاقی شود. بازشناسی اینکه وظیفه او کاهش رنج و ارایه حمایت است، نه حل همه بحران، می‌تواند محافظت‌کننده باشد.

پذیرش محدودیت ظرفیت فردی نشانه ناکارآمدی نیست.

۶. حفظ حس کارآمدی از طریق توجه به دستاوردهای روزانه

در شرایطی که درمانگران ممکن است با احساس تاثیرگذار نبودن یا فرسودگی مواجه شوند، توجه آگاهانه به اقدامات معنادار روزمره می‌تواند به حفظ حس کارآمدی حرفه‌ای کمک کند. به رسمیت شناختن این تلاش‌های کوچک روزمره، می‌تواند اثری محافظتی در برابر فرسودگی داشته باشد.

مثال: یادداشت کردن سه مورد کمک به دیگران در پایان روز، مثلاً فراهم کردن فضای امن برای سوگواری، کمک به تنظیم هیجان یک مراجع، یا پیش‌گیری از تشدید بحران می‌تواند یادآور اثرگذاری واقعی کار باشد.

۷. تنظیم نگرانی‌های مزمن

اشتغال ذهنی مداوم با تهدیدها، اخبار، یا نگرانی‌های آینده می‌تواند خود به منبع فرسودگی تبدیل شود. استفاده از راهبردهایی برای محدود کردن زمان پرداختن به نگرانی‌ها، ایجاد فاصله‌های کوتاه از اخبار و بازگشت آگاهانه به لحظه اکنون، می‌تواند به تنظیم فشار روانی کمک کند.
یکی از تکنیک‌های اثربخش برای مدیریت نگرانی‌ها و جلوگیری از فرسودگی روانی، اختصاص زمان مشخص برای نگرانی به نام «زمان نگرانی» است. در این روش، فرد آگاهانه تصمیم می‌گیرد که نگرانی‌های خود را به زمانی مشخص موکول کند تا در بقیه ساعت‌های روز، بتواند تمرکز خود را حفظ کند.

چگونه این کار را انجام دهیم؟

در ابتدا، زمانی از روز را به مدت ۱۵ دقیقه برای نگرانی تعیین کنید. می‌توانید یک آلارم روی گوشی خود تنظیم کنید تا به شما یادآوری کند که اکنون «زمان نگرانی» است. در این زمان، تمام نگرانی‌ها، افکار و اضطراب‌هایی را که در طول روز به ذهن شما می‌آید، بررسی کنید. اگر قبل از رسیدن به «زمان نگرانی» احساس فشار یا اضطراب کردید، به خودتان یادآوری کنید که «این موضوع را در زمان نگرانی فردا بررسی خواهم کرد.»

مثال: محدود کردن چک کردن اخبار به دو نوبت مشخص در روز، به جای پی‌گیری مداوم، می‌تواند سطح برانگیختگی مزمن را کاهش دهد.

این راهبردها جایگزین مواجهه واقع‌بینانه با بحران نیستند، بلکه کمک می‌کنند فرد در دل بحران، ظرفیت روانی خود را حفظ کند.

و در پایان به خاطر بسپارید خودمراقبتی در شرایط بحران، مجموعه‌ای از اقدامات کوچک، اما مستمر برای حفظ ظرفیت حرفه‌ای است: کمک خواستن، استراحت کردن، حفظ مرزها، پذیرش محدودیت‌ها، توجه به اثرگذاری‌های کوچک روزمره و تنظیم نگرانی‌های مزمن. این‌ها نشانه عقب‌نشینی از مسوولیت نیستند؛ بلکه راهی برای امکان ادامه دادن مسوولانه در شرایط دشوارند.

بخش ششم

ارجاع و ملاحظات فرهنگی حرفه‌ای

ارزیابی ایمنی و ارجاع به متخصص

در مواردی که شدت علامت‌های (سوگ، تروما، سایر مشکلات سلامت روان) یا سطح خطر به‌گونه‌ای است که مداخله حمایتی به‌تنهایی کفایت نمی‌کند، ارجاع به خدمات تخصصی روان‌پزشکی ضروری است. تشخیص به‌موقع این موقعیت‌ها بخشی از مسوولیت حرفه‌ای متخصصان سلامت روان است و به معنای ناکارآمدی مداخله حمایتی نیست. موارد زیر نیازمند توجه فوری و بررسی دقیق‌تر هستند:

- افکار آسیب‌به‌خود یا خودکشی
- سایکوز[۱۳] (روان‌پریشی) حاد
- تشدید پیش‌رونده علامت‌های اضطرابی یا افسردگی، یا سوگ پیچیده (وجود افکار خودکشی یا احساس گناه زیاد نسبت به متوفی)
- ناتوانی شدید و پایدار در عملکرد
- بیماری زمینه‌ای روان‌پزشکی

در مواجهه با این نشانه‌ها:

- ارزیابی خطر انجام دهید؛ یعنی درباره افکار آسیب به خود به صورت مستقیم سوال بپرسید، سابقه قبلی اقدام به خودکشی، وجود برنامه، دسترسی به ابزار و میزان حمایت در دسترس را بررسی کنید.

- حفظ ایمنی بیمار را در اولویت قرار دهید؛ در صورت وجود خطر جدی، فرد نباید تنها رها شود و باید به خدمات تخصصی یا اورژانسی ارجاع شود.

- منابع درمانی ایمن و در دسترس را معرفی کنید؛ به عنوان مثال مراکز درمانی در منطقه، همکاران متخصص در دسترس، یا خطوط بحران معتبر (مانند سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت، خط بحران سازمان نظام پزشکی ۸۴۱۳۸۸۸۸) . به فرد حق انتخاب برای استفاده از مرکز درمانی یا متخصص موردنظرش بدهید.

[۱۳] Psychosis

- به صورت حداقلی و ایمن کارهای انجام شده را مستندسازی کنید؛ از ثبت یا نگهداری اطلاعات حساس در بسترهای ناامن خودداری کنید و محرمانگی را در چارچوب قانون و ایمنی رعایت کنید.
- در صورت نیاز، با همکار ارشد خود مشورت کنید.

ملاحظه‌های فرهنگی، حرفه‌ای و اخلاقی

انطباق فرهنگی

در بافت متنوع فرهنگی ایران، لازم است متخصصان سلامت روان تنوع تجربه و ابراز سوگ و تروما را در نظر داشته باشند. مداخله‌های حمایتی باید با این زمینه فرهنگی هم‌خوان باشد و از زبان محترمانه، بدون قضاوت و حساس به فرهنگ منطقه استفاده کند. توجه به حساسیت‌های فرهنگی می‌تواند به افزایش پذیرش و اثربخشی مداخله کمک کند.

حفظ محرمانگی و مرزبندی حرفه‌ای

محرمانگی یکی از ارکان اعتماد در رابطه حمایتی است، اما محرمانگی مطلق امکان‌پذیر نیست. لازم است در آغاز تعامل، به‌روشنی توضیح داده شود که در صورت وجود خطر جدی برای خود فرد یا دیگران، اطلاعات ضروری در چارچوب حرفه‌ای با تیم درمانی در میان گذاشته خواهد شد. رعایت مرزهای حرفه‌ای، و پرهیز از نقش‌های دوگانه از اصول بنیادین اخلاق حرفه‌ای در این شرایط است.

بی‌طرفی و پرهیز از سوگیری

در ارایه حمایت روان‌شناختی، درمانگر یا تسهیل‌گر باید از قضاوت، جانبداری سیاسی یا تحمیل دیدگاه‌های شخصی پرهیز کند. تمرکز مداخله باید بر ارزش‌های مشترک و انسانی مانند همدلی، احترام، مسوولیت‌پذیری و حفظ کرامت باشد. بی‌طرفی به معنای بی‌تفاوتی نیست، بلکه به معنای حفظ فضای امنی است که در آن افراد با دیدگاه‌های متفاوت بتوانند بدون ترس از قضاوت سخن بگویند. تمامی مداخله‌های باید بر پایه شواهد علمی، اصول حرفه‌ای و نیازهای واقعی فرد یا گروه طراحی و اجرا شوند.

منابع

American Psychological Association. (n.d.). *Disasters and mental health*. https://www.apa.org/topics/disasters-response

Bujarski, S., Norberg, M. M., & Copeland, J. (2012). The association between traumatic experiences and alcohol use disorder: A review of the literature. *Addictive Behaviors, 37*(6), 605–614.

Center for Community Health and Development, University of Kansas. (n.d.). *Starting a support group*. Community Tool Box. https://ctb.ku.edu

Chidiebere, N. O., Omole, O., & Adebayo, A. (2023). Effectiveness of peer support in mental health: A scoping review. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 20*(5), 4536. https://www.mdpi.com/1660-4601/20/5/4536

Flory, K., Hankin, B. L., Kloos, B., Cheely, C., & Turecki, G. (2009). Alcohol and cigarette use and misuse among Hurricane Katrina survivors: Psychosocial risk and protective factors. *Substance Use & Misuse, 44*(12), 1711–1724.

Frontiers in Public Health. (2025). Barriers and facilitators to implementing peer support roles in mental health services: A systematic review. *Frontiers in Public Health, 13*, 1737709.

Gillard, S., Foster, R., Gibson, S., Goldsmith, L., Marks, J., & White, S. (2021). Describing a principles-based approach to developing and evaluating peer worker roles as peer support moves into mainstream mental health services. *BMC Psychiatry, 21*, 315. https://doi.org/10.1186/s12888-021-03321-z

Goldmann, E., & Galea, S. (2014). Mental health consequences of disasters. *Annual Review of Public Health, 35*, 169–183.

Goldstein, E., et al. (2024). Trauma-informed care implementation in health care systems: A systematic review and realist synthesis. *Psychological Services, 21*(4), 849–862. https://doi.org/10.1037/ser0000737

Inter-Agency Standing Committee. (2007). *Guidelines on mental health and psychosocial support in emergency settings*. World Health Organization. https://www.who.int/publications/i/item/iasc-guidelines-for-mental-health-and-psychosocial-support-in-emergency-settings

Jackson, E. R., Shanafelt, T. D., Hasan, O., Satele, D. V., & Dyrbye, L. N. (2016). Burnout and alcohol abuse/dependence among U.S. medical students. *Academic Medicine, 91*(9), 1251–1256.

Lyons, N., Cooper, C., & Lloyd-Evans, B. (2021). A systematic review and meta-analysis of group peer support interventions for people experiencing mental health conditions. *BMC Psychiatry, 21*, 315. https://doi.org/10.1186/s12888-021-03321-z

McCabe, S. E., West, B. T., Teter, C. J., & Boyd, C. J. (2014). Medical and nonmedical use of prescription benzodiazepine anxiolytics among U.S. adults. *Journal of Clinical Psychiatry, 75*(1), 40–46.

Neimeyer, R. A. (n.d.). *Meaning reconstruction in grief*.

NHS England. (2022). *Peer support: Supporting implementation in health and care*. https://www.england.nhs.uk/long-read/peer-support/

O'Connor, D., & Smith, K. (2023). Peer support in mental health services: Challenges and facilitators. *PubMed*. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37702192/

Oreskovich, M. R., Kaups, K. L., Balch, C. M., et al. (2012). Prevalence of alcohol use disorders among American surgeons. *Archives of Surgery, 147*(2), 168–174.

Patel, V., & Kumar, S. (2024). Peer-delivered interventions in mental health services: Evidence from a systematic review. *BMC Medicine, 22*, 3260. https://doi.org/10.1186/s12916-024-03260-y

Smith, J., & Jones, L. (2025). Peer support programs for healthcare workers: Barriers and benefits. *Social Science & Medicine, 180*, 1184.

Trinkoff, A. M., Zhou, Q., Storr, C. L., & Soeken, K. L. (2000). Workplace access, negative proscriptions, job strain, and substance use in registered nurses. *Nursing Research, 49*(2), 83–90.

Vujanovic, A. A., Lebeaut, A., & Leonard, S. (2018). PTSD symptom severity, dissociation, and substance use among trauma-exposed adults. *Journal of Dual Diagnosis, 14*(3), 197–206.

Williams, R., & Thompson, P. (2025). Group peer support in trauma care: Implementation and outcomes. *The Lancet Regional Health – Europe, 9*, 69–86.

World Health Organization. (2016). *mhGAP intervention guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health settings (Version 2.0)*. World Health Organization. https://www.who.int/publications/i/item/9789241549790

World Health Organization, War Trauma Foundation, & World Vision International. (2011). *Psychological first aid: Guide for field workers*. World Health Organization.

اسنایدر، ل.، ون اُمرن، م.، و شیفر، آ. (۱۳۹۲). *کمک‌های اولیه روان‌شناختی: راهنمای میدانی برای کارکنان* (ر. فرامرزی، مترجم). تهران: انتشارات اندیشمند.

پیوست

سناریوی تمرینی کمک‌های اولیه روان‌شناختی

سناریوی ۱

«رزیدنت پس از جنگ: خستگی پنهان و افت عملکرد»

زمینه

- مکان: بیمارستان آموزشی در شهری که به‌تازگی از وضعیت جنگی خارج شده
- وضعیت کلی: کاهش نسبی فشار، بازگشت تدریجی به روال عادی
- بسیاری از کارکنان هنوز تحت استرس هستند.

شخصیت‌ها

نقش ۱: «رضا» رزیدنت سال دوم طب اورژانس
در طول جنگ: شیفت‌های بسیار سنگین گاهی ۲۴–۳۶ ساعته داشته است. به دلیل بسته بودن خوابگاه، دو هفته در بیمارستان زندگی کرده و از خانواده دور بوده. احساس ناامنی به علت حملات هوایی مکرر و اخبار نگران‌کننده و مواجهه مکرر با مرگ و کمبود امکانات و تصمیم‌های دشوار داشته است.

وضعیت فعلی رضا: کند شدن در تصمیم‌گیری، اشتباهات کوچک ولی مکرر، خستگی شدید، فاصله گرفتن از همکاران، تحریک‌پذیری

نقش ۲: «سارا» رزیدنت سال چهارم جراحی، متوجه تغییر رفتار رضا شده است.

رضا در اتاق استراحت نشسته، به گوشی نگاه می‌کند اما تمرکز ندارد. وقتی با او صحبت می‌شود، کوتاه جواب می‌دهد و زود بحث را می‌بندد. سارا متوجه تغییر رفتار و افت عملکرد اخیر او شده و تصمیم می‌گیرد با او صحبت کند.

شروع گفتگو:

سارا: چند روزه دیدم خیلی خسته‌ای... خواستم ببینم حالت چطوره؟

رضا: چیز خاصی نیست، خوبم

سارا: این مدت خیلی سخت گذشت... چند تا کشیک داشتی؟

رضا: خیلی بد بود... هنوز انگار از اون فضا درنیومدم. فکر کنم دیگه اون آدم قبلی نمیشیم.

سارا: با توجه به اون شرایط، کاملاً قابل درکه که هنوز خسته باشی. خیلی‌هامون بعد از اون فشارها همین حس رو داریم. بدن و ذهن زمان می‌خواد تا برگرده به حالت عادی.

رضا: هیچ کاری ازم برنمیاد.

سارا: تو اون شرایط خیلی کارها رو مدیریت کردی... الان طبیعی است که یه کم زمان بخوای. بد نیست یک زمان استراحت کوتاه بگیری. با بچه‌ها صحبت کن چند روز مرخصی بگیری.

رضا: نمی‌دونم، انگیزه استراحت هم ندارم. باید گزارش یک پروژه را هم آماده کنم.

سارا: قابل درکه ولی خب چند روزی دور بودن از کار کمک می‌کنه. با استادت صحبت کن زمان را تمدید کنی دو سه هفته. امروز کاری هست من بتونم کمک کنم؟

رضا: ممنون. اگر موردی بود میگم.

نکات کلیدی در این سناریو

چه کاری نباید انجام داد؟

- دیگه تموم شده.
- بی‌خیال پروژه.
- تو که قوی بودی، چرا اینجوری شدی.
- بقیه هم همین‌طوری هستن مهم نیست درست میشه.
- خودت را مشغول کن بهش فکر نکن.

نشانه‌های نیاز به ارجاع

اگر رضا:

- نتواند کار کند.
- اشتباهات خطرناک داشته باشد.
- علائم شدید (بی‌خوابی، بی‌حسی، افکار آسیب به خود) داشته باشد.

سناریوی ۲

«شیفت سنگین در بخش اورژانس پس از حمله»

زمینه

- مکان: بیمارستان دولتی در یک شهر درگیر جنگ
- پایان یک شیفت ۱۲ ساعته بعد از ورود تعداد زیادی مجروح
- شرایط:کمبود نیرو و تجهیزات، چند فوتی در شیفت، فشار شدید کاری و تصمیم‌های سخت

شخصیت‌ها

نقش ۱: «طاهره» پرستار، با تجربه متوسط، شاهد مرگ یک کودک بوده. خسته، بی‌قرار، اشک در چشم، احساس گناه و ناتوانی.

نقش ۲: «علی» سوپروایزر شیفت، با تجربه بالا.

طاهره در بخش نشسته، به زمین خیره شده و با وجودی‌که شیفتش تمام شده وسایلش را جمع نکرده و تمایلی به ترک محل ندارد. سوپروایزر متوجه وضعیت او می‌شود و به سمتش می‌رود.

علی: حالت خوبه؟
طاهره: نه، اون بچه... من نتونستم کاری کنم...کلا کاری از ما برنمیاد.
علی: خیلی شرایط سختی بود... قابل درکه که این حس رو داشته باشی. بیا استیشن بنشین من برات یک لیوان آب بیاورم.
طاهره: ممنون. می‌خواهم اینجا بمونم کمک کنم. نمی‌خواهم بروم خونه.
علی: الان ۱۲ ساعت کمک کردی و خیلی کار کردی. نیاز به استراحت داری. می‌خوای با یکی از بچه‌ها که بهش نزدیکی حرف بزنی؟
طاهره: بچه‌ها همه خسته‌ان.
علی: درسته و در این شرایط است که باید هوای خودمون و همدیگه را داشته باشیم.
طاهره: بله، فکر کنم بخوابم یک کم بهتر بشم.
علی: فکر خوبیه. اگر موافق باشی با یکی از همکارها هماهنگ کنم با هم بروید خونه. فردا باز صحبت می‌کنیم.

نکات کلیدی در این سناریو

هدف حل و فصل سریع تمام احساسات منفی نیست، حضور موثر است.

چه کاری نباید انجام داد؟

- اصلاح سریع گفته‌های طاهره مانند: نباید این فکر را بکنی.
- تقصیر تو نبود بهش فکر نکن.
- درسته کاری از ما برنمیاد.


انجمن علمی روانپزشکان ایران